

## DANH MỤC VIẾT TẮT

### Từ viết tắt

CTXH

NB

QLTH

### Diễn giải

Công tác xã hội

Người bệnh

Quản lý trường hợp

## **DANH MỤC BẢNG BIỂU**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Bảng 1. Thông tin nhân khẩu học của người bệnh | 12 |
| Bảng 2. Bảng kế hoạch hỗ trợ NB                | 23 |

## **DANH MỤC SƠ ĐỒ**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Sơ đồ 1. Sơ đồ phả hệ của NB    | 17 |
| Sơ đồ 2. Sơ đồ sinh thái của NB | 18 |
| Sơ đồ 3. Cây vấn đề của NB      | 19 |

## TÓM TẮT BÁO CÁO

Người bệnh T.T.T, 54 tuổi, quê Ninh Bình, nhập viện tại Khoa Phụ Ngoại A5 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 11/9/2025 với chẩn đoán u xơ tử cung và được phẫu thuật cắt tử cung. Sau mổ, người bệnh có biểu hiện đau, di chuyển hạn chế, sức khỏe yếu, lo lắng về khả năng hồi phục và chăm sóc bản thân. Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, chủ yếu làm nông nghiệp, nguồn thu nhập bấp bênh; con cái bận công việc nên không thể thường xuyên ở bên chăm sóc.

Qua đánh giá tâm lý – xã hội toàn diện, học viên xác định ba nhu cầu ưu tiên của người bệnh: (1) được hướng dẫn cụ thể về chăm sóc vết mổ và lịch tái khám; (2) được tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm phục hồi thể trạng; (3) được hỗ trợ tâm lý để giảm lo lắng và tăng tinh thần tích cực. Từ đó, học viên xây dựng kế hoạch quản lý trường hợp với hai mục tiêu cụ thể: (1) cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc và vệ sinh vết mổ đúng cách; (2) hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật. Các hoạt động được triển khai trong 3 buổi can thiệp chính, có sự phối hợp giữa học viên công tác xã hội, bác sĩ điều trị, điều dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng và người nhà người bệnh.

Kết quả thực hiện cho thấy người bệnh đã đạt được những thay đổi rõ rệt cả về thể chất và tinh thần. Sau hoạt động kết nối với bác sĩ, người bệnh hiểu rõ lịch tái khám, biết cách theo dõi các dấu hiệu bất thường và yên tâm hơn về việc tiếp tục điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh. Sau khi được điều dưỡng hướng dẫn, người bệnh nắm chắc quy trình chăm sóc vết mổ, chủ động vệ sinh đúng cách và giảm lo sợ biến chứng. Buổi tư vấn dinh dưỡng giúp người bệnh thay đổi nhận thức về chế độ ăn, biết lựa chọn thực phẩm phù hợp, cải thiện thể lực và ăn ngon miệng hơn. Tình trạng tâm lý của người bệnh cải thiện rõ rệt: từ lo lắng, mệt mỏi chuyển sang tự tin, lạc quan, chủ động chia sẻ và hợp tác với nhân viên y tế. Người nhà cũng nắm vững kiến thức chăm sóc, thể hiện vai trò tích cực trong hỗ trợ người bệnh.

Quá trình lượng giá cuối cùng xác nhận NB đạt được hầu hết các mục tiêu đặt ra, thể trạng ổn định, tinh thần tích cực, không còn lo âu và đã sẵn sàng tự chăm sóc sau ra viện.

## **PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP**

### **1. Thông tin chung cơ sở thực tập**

#### ***1.1 Lịch sử hình thành và phát triển bệnh viện***

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được thành lập ngày 21/11/1979 theo Quyết định số 4951/QĐ-TC của UBND Thành phố Hà Nội, là món quà của Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Thế giới tặng phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Trụ sở chính đặt tại đường La Thành, quận Ba Đình, với diện tích hơn 19.500 m<sup>2</sup>, vị trí thuận lợi gần trung tâm thành phố (1).

Từ một cơ sở nhỏ hơn 100 giường, đến nay bệnh viện đã phát triển thành bệnh viện đầu ngành sản phụ khoa của Thủ đô và tuyến cuối chuyên khoa của Bộ Y tế, với hơn 700 giường bệnh, 41 khoa, phòng, trung tâm, và trên 1.500 cán bộ, nhân viên. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 720.000 lượt khám ngoại trú, 74.000 lượt nội trú, thực hiện hơn 40.000 ca sinh, 20.000 ca phẫu thuật và hàng chục nghìn thủ thuật chuyên sâu.

Trong hơn 40 năm phát triển, bệnh viện không ngừng hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, triển khai 07 mũi nhọn chuyên sâu về sản phụ khoa, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ Thủ đô và các tỉnh lân cận.

#### ***1.2. Cơ cấu tổ chức***

Bệnh viện gồm 4 khối chính: Khối phòng chức năng (9 phòng, 2 tổ, 1 ban, 1 bộ phận), trong đó Phòng Công tác xã hội là nơi học viên thực tập. Khối lâm sàng (21 khoa), gồm nhiều khoa điều trị sản, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, hỗ trợ sinh sản. Khối cận lâm sàng (7 khoa), đảm nhiệm chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, dược. Khối trung tâm (6 trung tâm và 1 cơ sở trực thuộc) (2).

#### ***1.3 Chức năng và nhiệm vụ***

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có chức năng khám, cấp cứu và điều trị các bệnh lý sản, phụ khoa; đào tạo – chỉ đạo tuyến – hợp tác quốc tế; và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sản phụ khoa. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm (3):

- Khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản; sàng lọc ung thư, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

- Đào tạo cán bộ y tế các trình độ, tổ chức tập huấn và đào tạo liên tục cho tuyến dưới.

- Thực hiện đề tài nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền.

- Là đầu mối chỉ đạo tuyến dưới, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong thành phố.

- Tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản cộng đồng; triển khai chương trình kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, vị thành niên, nam giới, người cao tuổi.

- Hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế theo quy định của Nhà nước, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách và các dịch vụ y tế.

#### ***1.4. Thành tích nổi bật của bệnh viện (4)***

Năm 1999: Huân chương Lao động hạng Nhì

Năm 2002: Huân chương Lao động hạng Nhất

Năm 2008: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen Bộ Y tế.

Năm 2010: Bằng khen của UBND Thành phố “Bệnh viện đã được bình chọn là một trong những cơ sở khám và điều trị sản phụ khoa tốt nhất trong nước”.

Năm 2014, 2016, 2017: Cờ Thi đua của Bộ Y tế

Năm 2018, 2019: Cờ chính phủ, Huân chương lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ Quốc.

Năm 2020: Danh hiệu đơn vị “ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, Cờ thi đua của Bộ Y tế giai đoạn 2016 - 2020 cho tập thể Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Cờ thi đua: Đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phong trào thanh niên quận Ba Đình năm 2020

Năm 2021: Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” cho tập thể Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2021. Bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương.

Năm 2022: Giấy khen thưởng đột xuất công tác đảm bảo y tế phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

## **2. Thông tin chung về Phòng Công tác xã hội**

### **2.1 Lịch sử hình thành và phát triển**

Phòng Công tác xã hội (CTXH) – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được thành lập ngày 25/01/2016 theo Quyết định số 132/QĐ–SYT của Sở Y tế Hà Nội. Sự ra đời của phòng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hỗ trợ toàn diện người bệnh và gia đình trong quá trình khám chữa bệnh (5).

Từ khi thành lập đến nay, phòng CTXH không ngừng lớn mạnh, dần khẳng định vai trò là cầu nối giữa người bệnh – nhân viên y tế – cộng đồng. Phòng đã xây dựng được mạng lưới hoạt động hiệu quả trong toàn viện, đồng thời mở rộng hợp tác với các chuyên gia, tổ chức quốc tế, tổ chức các khóa học và buổi trao đổi chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghề công tác xã hội trong môi trường y tế hiện đại.

### **2.2 Cơ cấu tổ chức**

Hiện nay phòng CTXH có tổng nhân sự gồm 31 nhân viên (02 Viên chức, 29 HĐ 111), bao gồm:

- Phó Trưởng phòng: ThS. Đoàn Minh Thục
- Các tổ chuyên trách: Tổ Chăm sóc khách hàng, Tổ Hợp tác quốc tế, Tổ Thư ký Ban Giám đốc, Tổ Bảo lãnh viện phí
- Các bộ phận nghiệp vụ: Tuyên truyền – tổ chức sự kiện, An sinh xã hội cho nhóm đối tượng ưu tiên, Hỗ trợ người bệnh và nhân viên y tế, Hành chính

Bộ máy được phân công rõ ràng, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác chuyên môn, chăm sóc khách hàng và kết nối cộng đồng.

### **2.3 Chức năng và nhiệm vụ**

Phòng CTXH là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, có chức năng tham mưu, tổ chức và triển khai các hoạt động công tác xã hội trong toàn viện. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

- Truyền thông – tuyên truyền: Đăng tải tin, bài, sự kiện; quản lý fanpage; tư vấn và phản hồi thông tin cho người dân, quảng bá hình ảnh bệnh viện.
- An sinh xã hội: Tổ chức, vận động các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ nhóm người bệnh nghèo, khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; kết nối các nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội.

- Hỗ trợ người bệnh và nhân viên y tế: Tiếp nhận, hỗ trợ các ca khó khăn, thăm hỏi, lắng nghe và giải đáp phản hồi; góp phần tạo môi trường khám chữa bệnh thân thiện, nhân văn.

- Chăm sóc khách hàng: Tiếp đón, tư vấn, hướng dẫn tại khu khám bệnh; thực hiện gọi điện chăm sóc sau ra viện; tiếp nhận và xử lý phản ánh.

- Tổ chức sự kiện và hợp tác quốc tế: Tiếp đón các đoàn chuyên gia, tổ chức hội thảo, giao lưu quốc tế; tham gia đào tạo, bồi dưỡng công tác xã hội cho nhân viên y tế.

- Đào tạo và nghiên cứu: Là cơ sở thực hành cho học viên công tác xã hội; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ; tham gia mạng lưới CTXH liên viện.

#### ***2.4 Các hoạt động công tác xã hội đang được thực hiện***

Phòng CTXH hiện triển khai đa dạng các hoạt động hướng đến người bệnh và cộng đồng:

- Tuyên truyền – kết nối cộng đồng: Truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản, an toàn tình dục, phòng chống ung thư cổ tử cung; duy trì quan hệ báo chí và quảng bá hình ảnh bệnh viện.

- An sinh xã hội: Phát động các chương trình thiện nguyện, vận động tài trợ thiết bị y tế, thăm và tặng quà cho người bệnh khó khăn, như chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” – miễn phí chu kỳ IVF cho các gia đình nghèo.

- Hỗ trợ người bệnh: Hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ thanh toán viện phí, tổ chức thăm hỏi và ghi nhận phản hồi người bệnh.

- Hợp tác quốc tế: Phối hợp với Đại học Harvard, Stanford, Viện Karolinska và WHO trong đào tạo, trao đổi chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

- Chăm sóc khách hàng: Đảm nhiệm hàng trăm nghìn lượt tư vấn, đón tiếp và cuộc gọi chăm sóc sau ra viện.

- Tổ chức sự kiện: Điều phối các sự kiện lớn của bệnh viện như ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Ngày CTXH 25/3, 8/3, 1/6, các hội nghị, hội thảo, chương trình tri ân.

- Đào tạo và thực hành: Đón tiếp, hướng dẫn học viên Đại học Y tế công cộng thực tập; đào tạo nhân viên mới về nghiệp vụ công tác xã hội.

#### ***2.5 Thành tích nổi bật***

Từ năm 2016 đến nay, phòng CTXH đã đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Hỗ trợ 86 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nhận và xử lý 162 sự vụ.

Chăm sóc khách hàng: 414.435 lượt đón tiếp, 156.220 cuộc gọi hậu mãi.

Giáo dục sức khỏe cộng đồng: 77 buổi truyền thông cho hơn 40.000 học sinh, học viên.

Hợp tác quốc tế: Tổ chức hội thảo quốc tế về gây mê hồi sức sản khoa (2019); thiết lập mạng lưới hợp tác với các tổ chức y tế quốc tế.

An sinh xã hội: Vận động hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người bệnh khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh.

Thành tích: Năm 2024, phòng được Sở Y tế Hà Nội khen thưởng vì thành tích xuất sắc; Nguyên trưởng phòng ThS.BS Vũ Thị Thu Hiền được vinh danh cá nhân tiêu biểu.

### **3. Đánh giá hoạt động quản lý trường hợp tại cơ sở thực tập**

#### ***3.1. Thực trạng triển khai hoạt động quản lý trường hợp***

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hoạt động quản lý trường hợp (QLTH) trong công tác xã hội chưa được triển khai chính thức và hệ thống hóa. Hiện nay, phòng CTXH mới thực hiện một số dịch vụ CTXH cơ bản như: tư vấn sức khỏe sinh sản, hỗ trợ thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận phản hồi, điều phối vận động tài trợ và phối hợp các hoạt động an sinh xã hội cho nhóm đối tượng ưu tiên.

Mặc dù nhiều nội dung trong các hoạt động này có bản chất gần với quy trình quản lý trường hợp, song chưa có bộ quy trình QLTH cụ thể, chuẩn hóa và văn bản hóa để hướng dẫn nhân viên thực hiện theo từng giai đoạn (tiếp nhận, đánh giá, lập kế hoạch, can thiệp, lượng giá, kết thúc). Do đó, công tác hỗ trợ người bệnh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân, tính linh hoạt của nhân viên CTXH và chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo phòng.

#### ***3.2. Điểm mạnh và hạn chế trong triển khai hoạt động QLTH tại cơ sở thực tập***

Mặc dù chưa có mô hình QLTH chính thức, hoạt động CTXH tại bệnh viện vẫn thể hiện nhiều điểm mạnh đáng ghi nhận:

- Đội ngũ nhân viên có chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nắm bắt hoàn cảnh của người bệnh để kết nối nguồn lực hỗ trợ kịp thời.

- Mạng lưới hỗ trợ đa dạng, bao gồm các tổ, bộ phận chuyên trách như chăm sóc khách hàng, an sinh xã hội, bảo lãnh viện phí... giúp quy trình hỗ trợ người bệnh diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

- Hệ thống truyền thông và kết nối cộng đồng mạnh, giúp việc vận động tài trợ, huy động nguồn lực xã hội và lan tỏa các giá trị nhân văn được thực hiện thường xuyên.

- Tinh thần hợp tác nội viện tốt, nhân viên CTXH phối hợp chặt chẽ với bác sĩ, điều dưỡng và các khoa phòng trong xử lý tình huống, tư vấn, và chăm sóc tinh thần cho người bệnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động QLTH tại bệnh viện vẫn còn một số hạn chế và thách thức:

- Chưa có quy trình quản lý trường hợp chính thức, dẫn đến việc thực hiện còn rời rạc, thiếu tính thống nhất giữa các nhân viên.

- Chưa có bộ công cụ đánh giá và lượng giá cụ thể, khiến việc theo dõi tiến trình và hiệu quả can thiệp chưa được định lượng rõ ràng.

- Thiếu nhân lực chuyên trách về QLTH, các nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều mảng như truyền thông, chăm sóc khách hàng, sự kiện, làm giảm thời gian dành cho từng ca.

- Chưa có hoạt động đào tạo, tập huấn chuyên sâu về quy trình QLTH trong y tế, dẫn đến sự khác biệt trong cách hiểu và cách làm giữa các nhân viên.

### **3.3. Bài học kinh nghiệm**

Từ thực tiễn triển khai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng cho việc phát triển mô hình quản lý trường hợp trong công tác xã hội y tế:

- Cần xây dựng và chuẩn hóa quy trình QLTH theo đúng các giai đoạn của tiến trình công tác xã hội (tiếp nhận – đánh giá – lập kế hoạch – can thiệp – lượng giá – kết thúc), phù hợp với đặc thù bệnh viện chuyên khoa.

- Đào tạo và bồi dưỡng năng lực QLTH cho nhân viên CTXH là yếu tố cốt lõi, giúp họ có khả năng đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch và huy động nguồn lực hiệu quả hơn.

- Tăng cường phối hợp liên ngành giữa CTXH, y tế, tài chính và các tổ chức xã hội để hình thành mạng lưới hỗ trợ thống nhất cho người bệnh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, theo dõi tiến trình và đánh giá kết quả can thiệp, nhằm đảm bảo tính liên tục và minh bạch.

- Chú trọng lượng giá và phản hồi từ người bệnh để hoàn thiện mô hình, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ.

Nhìn chung, hoạt động quản lý trường hợp tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mới ở giai đoạn nền tảng, tập trung vào các dịch vụ hỗ trợ cơ bản. Tuy nhiên, với tiềm năng về đội ngũ nhân lực, hệ thống tổ chức và mạng lưới xã hội rộng, bệnh viện có điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình QLTH chính thức trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, nhân văn và bền vững cho người bệnh.

## PHẦN 2. TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP

### Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

#### 1.1. Tiếp nhận đối tượng

##### a) Lý do lựa chọn và quá trình tiếp cận

Trong thời gian thực tập quản lý trường hợp tại Khoa Phụ Ngoại A5 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, học viên được hướng dẫn tiếp cận một số người bệnh (NB) đang điều trị tại đây. Trong số đó, học viên đã lựa chọn người bệnh T.T.T (54 tuổi, quê quán Bắc Lý, Ninh Bình) để triển khai quản lý trường hợp vì có nhiều yếu tố phù hợp để áp dụng đầy đủ các bước trong quy trình quản lý trường hợp. Người bệnh nhập viện ngày 11/9/2025 với chẩn đoán u xơ tử cung và được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt tử cung vào ngày 12/9/2025. Học viên tiếp cận với người bệnh vào ngày 16/9/2025 khi người bệnh đang nằm điều trị tại phòng 509. Học viên tiếp cận trực tiếp NB tại giường bệnh, có sự đồng ý của bác sĩ điều trị và điều dưỡng phụ trách. Trong buổi đầu, học viên giới thiệu bản thân, vai trò và mục đích tiếp cận nhằm hỗ trợ kết nối NB với các nguồn lực phù hợp để giải quyết những sự lo lắng của mình.

NB vừa trải qua phẫu thuật lớn nên có đôi chút lo lắng về nguy cơ tái phát bệnh. Hiện tại chỉ có con gái lớn chăm sóc tại viện, sau đó khi xuất viện có thể sẽ phải tự chăm sóc. Qua trao đổi, người bệnh bày tỏ mong muốn được tư vấn thêm về cách chăm sóc sau mổ và chế độ ăn uống phù hợp, đồng thời hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục để sớm quay về chăm sóc bố và tham gia các công việc gia đình. Trong quá trình tiếp cận học viên nhận thấy NB hợp tác, sẵn sàng chia sẻ thông tin, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tại khoa hỗ trợ tích cực, hồ sơ y tế đầy đủ, thuận lợi cho việc thu thập thông tin và đánh giá toàn diện. Đồng thời vấn đề của NB phù hợp với khả năng của học viên và có thể hỗ trợ cho NB trong thời gian thực tập.

Học viên đã sử dụng mẫu Phiếu tiếp nhận và đánh giá ban đầu (Phụ lục 1.1) để thu thập các thông tin tiếp nhận ban đầu và đánh giá nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp của NB.

##### b) Thông tin sơ lược của người bệnh

**Bảng 1. Thông tin nhân khẩu học của người bệnh**

|            |       |
|------------|-------|
| Họ và tên: | T.T.T |
|------------|-------|

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Giới tính:</b>            | Nữ                                |
| <b>Năm sinh:</b>             | 1971 (54 tuổi)                    |
| <b>Dân tộc:</b>              | Kinh                              |
| <b>Tôn giáo:</b>             | Không                             |
| <b>Quê quán:</b>             | Bắc Lý, Ninh Bình                 |
| <b>Nghề nghiệp:</b>          | Nông nghiệp                       |
| <b>Bệnh điều trị:</b>        | U xơ tử cung (đã được phẫu thuật) |
| <b>Khoa/ phòng điều trị:</b> | Phòng 509, khoa A5                |
| <b>Tình trạng hôn nhân:</b>  | Đã kết hôn                        |
| <b>Trình độ học vấn :</b>    | 12/12                             |

**- Tình trạng sức khỏe thể chất:**

- + Sau phẫu thuật cắt tử cung, NB có biểu hiện đau vết mổ, di chuyển hạn chế, cần người hỗ trợ trong sinh hoạt cơ bản như vệ sinh cá nhân, thay băng vết mổ.
- + Trước mổ, NB có tiền sử rong kinh kéo dài và thiếu máu nhẹ.

**- Tình trạng sức khỏe tinh thần:**

- + NB có biểu hiện lo lắng nhẹ, chủ yếu về việc chăm sóc bản thân và nguy cơ tái phát bệnh.
- + Tỉnh táo có cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến biến chứng hậu phẫu.
- + Không có dấu hiệu rối loạn lo âu hoặc trầm cảm, khả năng hợp tác điều trị tốt.

*c) Đánh giá nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp của NB*

Thông qua kết quả đánh giá nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp của NB trong “Phiếu tiếp nhận và đánh giá ban đầu”, học viên ghi nhận NB không có nguy cơ bị bạo lực, bỏ rơi hay tự gây hại. Học viên nhận thấy NB không có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Hiện NB đang được điều trị và chăm sóc tích cực bởi đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện, đồng thời có sự hỗ trợ trực tiếp của con gái trong suốt quá trình nằm viện. Người bệnh được đảm bảo an toàn, tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần hợp tác tốt. Do đó không cần can thiệp khẩn cấp tại thời điểm đánh giá.

**1.2. Thu thập thông tin của đối tượng**

*a) Nguồn thu thập thông tin và công cụ thu thập thông tin*

Thông tin về NB được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau nhằm đảm bảo tính toàn diện, khách quan và độ tin cậy trong quá trình thu thập thông tin:

- **Người bệnh:** Học viên đã thu thập trực tiếp từ người bệnh các thông tin về đặc điểm nhân khẩu học, tình trạng sức khỏe hiện tại, sức khỏe tinh thần, hoàn cảnh xã hội, các mối quan hệ hỗ trợ cũng như khả năng tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

- **Người nhà người bệnh:** Bổ sung các thông tin chi tiết về điều kiện sống, khả năng tự chăm sóc, và sự hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày, qua đó làm rõ hơn bối cảnh xã hội và mức độ hỗ trợ của gia đình.

- **Bác sĩ và điều dưỡng:** Cung cấp thông tin quan trọng về tình trạng bệnh lý, quá trình điều trị, phác đồ điều trị và những khuyến nghị về chăm sóc sau phẫu thuật.

- **Nhân viên công tác xã hội:** Cung cấp thông tin về quy trình hỗ trợ, phương pháp tiếp cận và kế hoạch can thiệp được thực hiện đối với NB.

- **Bệnh án:** là nguồn thông tin chính thống, giúp xác minh các dữ liệu hành chính, tình trạng bệnh, và phác đồ điều trị cụ thể của người bệnh.

Trong quá trình thu thập thông tin, học viên sử dụng hai công cụ chính gồm:

- Phiếu đánh giá tâm lý – xã hội toàn diện (Phụ lục 1.2) để đánh giá toàn diện, có hệ thống các khía cạnh về thể chất, tâm lý và xã hội của NB. Phiếu đánh giá gồm 05 phần nội dung về các thông tin vấn đề, thông tin sức khỏe thể chất, tâm lý, hoàn cảnh gia đình và môi trường sống, hành vi sức khỏe và an toàn của NB; 01 nội dung về đánh giá nhu cầu hỗ trợ và 01 nội dung về kết luận của học viên.

- Bộ câu hỏi phỏng vấn sâu NB, nhằm khai thác chi tiết hơn về nhu cầu, cảm nhận, khó khăn cũng như nguồn lực cá nhân và gia đình.

#### *b) Thông tin về NB và vấn đề của NB*

Thông qua kết quả của Phiếu đánh giá tâm lý – xã hội toàn diện, kết quả đánh giá cho thấy NB vừa trải qua phẫu thuật cắt bỏ tử cung, hiện thể trạng còn yếu, thường xuyên đau tại vùng vết mổ và gặp khó khăn trong việc di chuyển. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tự chăm sóc, sinh hoạt và phục hồi của NB trong giai đoạn hậu phẫu. Do đó, cần ưu tiên chăm sóc hậu phẫu, hướng dẫn NB phòng ngừa biến chứng và hỗ trợ các hoạt động phù hợp với khả năng thể chất hiện tại. Về mặt tâm lý, NB có biểu hiện lo lắng nhẹ, chủ yếu liên quan đến quá trình hồi phục sức khỏe và khả năng tự chăm sóc bản thân sau khi xuất viện. Tuy nhiên, NB vẫn giữ được tinh thần hợp tác, có thái độ tích cực và chưa xuất hiện dấu hiệu của rối loạn tâm thần hay khủng hoảng cảm xúc. Điều này cho thấy NB có khả năng thích ứng

tương đối tốt, song vẫn cần được tư vấn tâm lý và hỗ trợ tinh thần thường xuyên để giúp ổn định cảm xúc và tăng cường sự tự tin trong quá trình hồi phục. Về mối quan hệ gia đình, NB sống cùng bố cao tuổi, con cái quan tâm và hỗ trợ, tuy nhiên do bận công việc nên không thể thường xuyên ở bên chăm sóc. Gia đình nhìn chung có thái độ tích cực, sẵn sàng hỗ trợ khi cần, song vẫn cần được hướng dẫn cụ thể trong việc phối hợp chăm sóc và hỗ trợ NB sau phẫu thuật. Về kinh tế, NB có thu nhập chính từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, không ổn định, và đang sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến, dẫn đến chi phí điều trị có thể gây áp lực tài chính. Tuy chưa ở mức khẩn cấp, nhưng tình hình kinh tế hạn chế có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sức khỏe và việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ lâu dài. Xét về nguồn lực xã hội, NB có những kết nối tích cực từ cộng đồng, đặc biệt là Hội Phụ nữ. Học viên có thể huy động sự quan tâm, động viên tinh thần và hỗ trợ trong giai đoạn hậu phẫu. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên y tế và học viên CTXH cũng là những nguồn lực quan trọng giúp NB được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ trong việc chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý. Tuy nhiên, các nguồn lực này cần được kết nối một cách hiệu quả và có kế hoạch rõ ràng để phát huy tối đa vai trò trong quá trình phục hồi của NB.

Từ kết quả phân tích trên, có thể xác định ba nhu cầu cấp thiết của NB gồm:

- (1) Được hướng dẫn cụ thể về chăm sóc vết mổ và lịch tái khám;
- (2) Được tư vấn về chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm phục hồi thể trạng;
- (3) Được hỗ trợ tâm lý nhằm giảm bớt lo lắng và tăng cường tinh thần tích cực trong quá trình điều trị và phục hồi.

Bên cạnh đó, học viên đã sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn sâu để thu thập chi tiết hơn các thông tin liên quan đến NB và vấn đề của NB. Theo đó, kết quả thu thập thông tin như sau:

- **Thông tin về vấn đề của NB:** NB cho biết ít khi đi khám sức khỏe định kỳ, chỉ đi khám khi có triệu chứng nặng. Khi nhận được chẩn đoán, NB cho biết bản thân rất sốc và hoang mang, tuy nhiên sau khi được bác sĩ tư vấn và gia đình động viên, NB đã chấp nhận phẫu thuật với mong muốn nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Hiện tại, NB vẫn đau do vết mổ, di chuyển hạn chế, cần có sự hỗ trợ trong các sinh hoạt cơ bản như vệ sinh cá nhân, thay băng và đi lại. NB chia sẻ do cơ thể suy nhược, mệt mỏi, sức đề kháng kém nên cảm thấy quá trình hồi phục diễn ra chậm hơn so với mong đợi. NB bộc lộ lo lắng nhẹ, chủ yếu xoay quanh việc hồi phục sức khỏe và khả

năng tự chăm sóc bản thân sau khi xuất viện. NB chia sẻ cảm giác sợ trở thành gánh nặng cho gia đình, đặc biệt khi các con không thể thường xuyên có mặt tại bệnh viện do bận công việc. Bên cạnh đó, NB cũng thiếu kiến thức về chăm sóc hậu phẫu và chế độ dinh dưỡng phù hợp, chưa nắm rõ cách phòng tránh biến chứng hoặc chăm sóc vết thương đúng cách. NB bày tỏ lo lắng về khả năng tái phát bệnh hoặc biến chứng sau phẫu thuật, điều này khiến tinh thần đôi lúc căng thẳng và thiếu tự tin trong quá trình điều trị.

**- Thông tin về hoàn cảnh gia đình và môi trường sống:** NB hiện đang sinh sống cùng bố đẻ tại vùng nông thôn. Gia đình NB có ba người con, trong đó con gái lớn đã lập gia đình, nhà chồng cách nơi ở của NB khoảng 3–4 km, có thể đến thăm và hỗ trợ khi cần nhưng không thường xuyên; con trai út chưa có công việc ổn định, vẫn phụ thuộc vào gia đình, vì là con trai nên cũng có nhiều hạn chế trong việc chăm sóc NB. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nhìn chung hòa thuận, gần gũi, có sự quan tâm lẫn nhau, tuy nhiên do điều kiện công việc và khoảng cách địa lý, sự hỗ trợ của con cái đối với NB trong giai đoạn nằm viện còn hạn chế.

Nguồn thu nhập chính của gia đình đến từ sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ, không ổn định và có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Điều này khiến gia đình đôi khi gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí điều trị, đặc biệt khi NB tham gia BHYT hộ gia đình nhưng điều trị trái tuyến tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nên phần chi trả bảo hiểm bị hạn chế.

NB sinh sống tại khu vực nông thôn có điều kiện giao thông thuận lợi, cách bệnh viện tuyến tỉnh khoảng 15 km, thuận tiện cho việc đi lại và tái khám. Khu dân cư có an ninh tốt, cộng đồng đoàn kết, không có biểu hiện kỳ thị hay xa lánh đối với NB, đây là nguồn lực xã hội tích cực giúp NB cảm thấy yên tâm và được chia sẻ.

**- Thông tin về cách ứng phó/cách giải quyết trước đây với vấn đề:** Khi xuất hiện triệu chứng rong kinh nặng, NB chủ động tìm đến phòng khám tư nhân để thăm khám và điều trị. Sau khi được chẩn đoán mắc u xơ tử cung, dù ban đầu khá lo lắng và sốc với chẩn đoán, NB đã bình tĩnh hơn sau khi được bác sĩ tư vấn và gia đình động viên, từ đó chủ động nhập viện và thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

**- Thông tin về khả năng tham gia của đối tượng trong các hoạt động can thiệp:** NB có nhận thức tốt, khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin hiệu quả, đồng thời

có tinh thần hợp tác và sẵn sàng tham gia các hoạt động tư vấn, hướng dẫn chăm sóc do nhân viên CTXH hoặc nhân viên y tế thực hiện. Đây là một yếu tố thuận lợi giúp quá trình hỗ trợ và can thiệp có thể đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, do thể trạng còn yếu trong giai đoạn đầu sau mổ, NB dễ mệt mỏi khi phải tham gia hoạt động trong thời gian dài, vì vậy cần sắp xếp lịch làm việc, tư vấn phù hợp với sức khỏe của NB, tránh gây áp lực thể chất và tâm lý.

- Thông tin về nguồn lực hỗ trợ đối tượng: NB hiện có nhiều nguồn lực hỗ trợ tích cực từ gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế. Trước hết, gia đình là nguồn lực quan trọng và gần gũi nhất. Mặc dù con cái của NB bận công việc nên không thể thường xuyên chăm sóc, nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm trong việc hỗ trợ mẹ về vật chất và tinh thần, đặc biệt là con gái lớn thường xuyên liên lạc, thăm hỏi và hỗ trợ khi cần thiết. Bố của NB tuy cao tuổi nhưng sống cùng, tạo cho NB cảm giác ấm áp và có chỗ dựa tinh thần khi trở về nhà sau xuất viện.

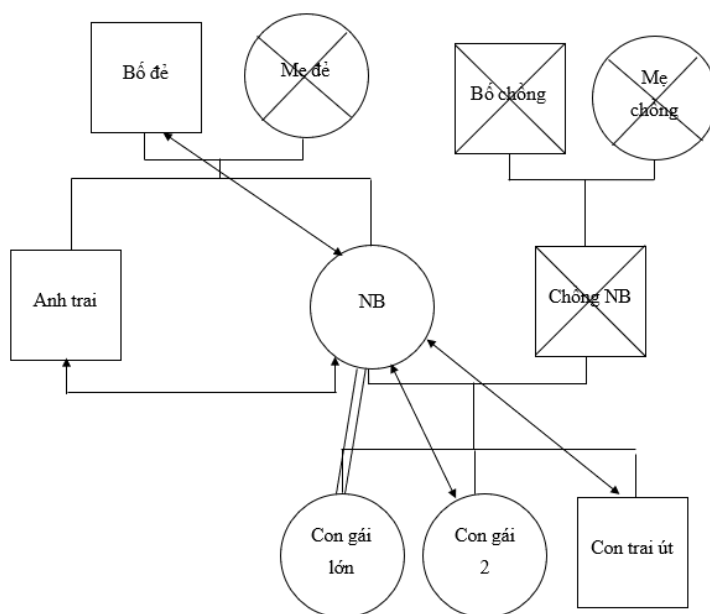
Ngoài gia đình, NB nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên CTXH tại bệnh viện. Đây là nguồn lực y tế đáng tin cậy, giúp NB được chăm sóc, theo dõi và tư vấn kịp thời trong quá trình hậu phẫu. Bên cạnh đó, học viên CTXH tham gia hỗ trợ cũng đóng vai trò cầu nối giữa NB với các dịch vụ tư vấn, giúp NB hiểu rõ hơn về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc vết mổ và các kỹ năng tự chăm sóc sau khi ra viện.

Ở cấp độ cộng đồng, NB có mối quan hệ tích cực với hàng xóm và các tổ chức đoàn thể địa phương, đặc biệt là Hội Phụ nữ. Đây là nguồn lực xã hội có thể huy động trong trường hợp NB cần sự giúp đỡ hoặc động viên tinh thần trong giai đoạn hồi phục. Bên cạnh đó, điều kiện an ninh tốt và môi trường sống ổn định cũng là yếu tố thuận lợi, giúp NB cảm thấy yên tâm và có động lực phục hồi.

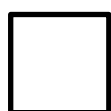
### ***1.3. Đánh giá toàn diện nhu cầu trợ giúp của NB***

#### ***a) Sơ đồ phả hệ của NB***

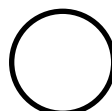
### Sơ đồ 1. Sơ đồ phả hệ của NB



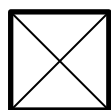
#### Chú thích ký hiệu:



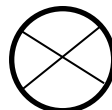
Nam



Nữ



Nam đã mất



Nữ đã mất

:

Quan hệ thân thiết



Quan hệ 2 chiều

#### Nhận xét:

Sơ đồ phả hệ thể hiện cấu trúc gia đình của NB gồm nhiều thế hệ, trong đó NB hiện đang sống cùng bố đẻ, là người cao tuổi và có sức khỏe yếu, cần được hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày. Mẹ đẻ của NB đã mất, do đó NB vừa là người được bố quan tâm, vừa đảm nhận vai trò chăm sóc tinh thần cho ông trong gia đình. NB còn có một người anh trai, tuy không sống cùng nhưng thỉnh thoảng hỗ trợ khi cần thiết, chủ yếu về mặt vật chất hoặc trong những tình huống đặc biệt.

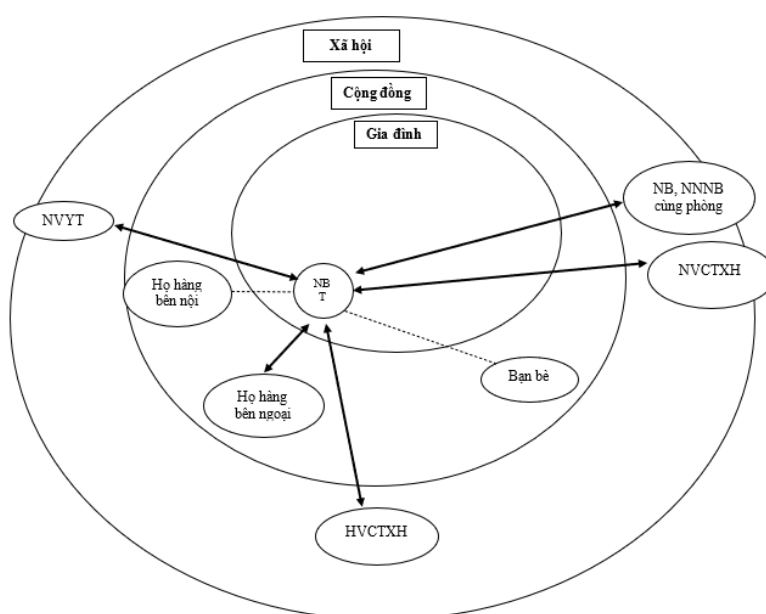
Về gia đình riêng, chồng của NB đã mất, để lại ba người con gồm hai con gái và một con trai út. Trong đó, con gái lớn đã lập gia đình, sống cách nhà khoảng 3–4 km, là người có mối quan hệ gắn bó và thường xuyên qua lại chăm sóc, hỗ trợ NB, đặc biệt trong giai đoạn nằm viện. Con gái thứ hai và con trai út đều còn trẻ, hỗ trợ ở

mức độ nhất định, tuy nhiên con trai út chưa có công việc ổn định và vẫn phụ thuộc kinh tế vào gia đình, nên khả năng giúp đỡ còn hạn chế.

Các mối quan hệ trong gia đình nhìn chung hòa thuận, gắn bó và có sự quan tâm lẫn nhau, thể hiện đây là một hệ thống gia đình có nền tảng tình cảm tích cực. Gia đình là nguồn lực chính của NB, mang lại sự hỗ trợ về tinh thần và một phần hỗ trợ thực tế trong sinh hoạt. Tuy nhiên, sự thiếu vắng người chăm sóc cố định khiến NB gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật, đặc biệt khi cần người hỗ trợ thường xuyên trong các hoạt động cơ bản.

#### b) Sơ đồ sinh thái của NB

**Sơ đồ 2. Sơ đồ sinh thái của NB**



#### Chú thích ký hiệu:

**X**                      Quan hệ 2 chiều                      .                      Quan hệ xa cách

#### Nhận xét:

Kết quả cho thấy NB có mạng lưới quan hệ tương đối hẹp, chủ yếu tập trung trong phạm vi gia đình và một số mối liên hệ tại bệnh viện trong giai đoạn điều trị.

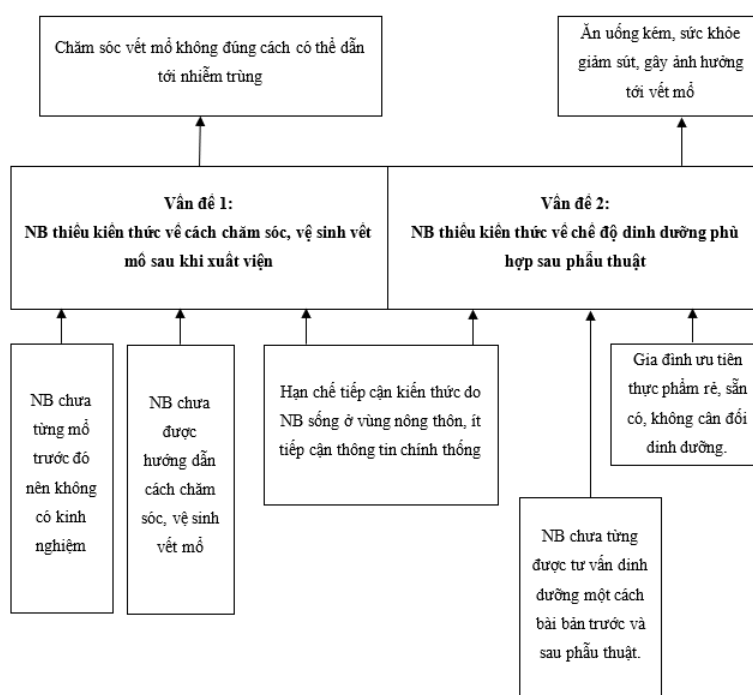
NB gần gũi với bên ngoại hơn so với bên nội. Sau khi chồng và bố mẹ chồng qua đời, mối quan hệ với gia đình chồng trở nên xa cách, ít duy trì liên hệ thường xuyên. NB hiện sống cùng bố đẻ cao tuổi, có sự hỗ trợ nhất định từ các con, tuy nhiên chưa có người chăm sóc cố định nên vẫn gặp khó khăn trong sinh hoạt và hồi phục

sức khỏe. Các mối quan hệ hai chiều giữa NB và họ hàng bên ngoại chủ yếu là quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ tinh thần khi cần.

NB ít giao tiếp với bạn bè, chủ yếu là đi làm rồi lại về nhà để chăm sóc cho bố đẻ. Tuy vậy, trong môi trường điều trị tại bệnh viện, NB đã thiết lập được các mối quan hệ tích cực với nhân viên y tế (NVYT), nhân viên công tác xã hội (NVCTXH), học viên CTXH và các NB khác cùng phòng. Đây là các mối quan hệ hai chiều, thể hiện sự tương tác, chia sẻ thông tin và hỗ trợ qua lại. NB nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của đội ngũ NVYT và NVCTXH về chăm sóc hậu phẫu, đồng thời chia sẻ, động viên tinh thần lẫn nhau với các NB cùng phòng.

### c) Cây vấn đề của NB

#### **Sơ đồ 3. Cây vấn đề của NB**



#### **Nhận xét:**

NB hiện đang đối mặt với hai vấn đề chính là: (1) Thiếu kiến thức về cách chăm sóc, vệ sinh vết mổ sau khi xuất viện, và (2) Thiếu kiến thức về chế độ dinh dưỡng phù hợp trong giai đoạn hậu phẫu. Đây là hai vấn đề có mối liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi sức khỏe của NB.

Vấn đề thứ nhất: thiếu kiến thức về chăm sóc và vệ sinh vết mổ sau khi xuất viện là vấn đề ưu tiên cần được can thiệp trước, bởi nếu không được hướng dẫn đúng

cách, NB có thể chăm sóc vết mổ sai quy trình, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, viêm hoặc chậm liền sẹo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất và tinh thần. Nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ việc NB chưa từng trải qua phẫu thuật trước đó nên thiếu kinh nghiệm, đồng thời chưa được hướng dẫn cụ thể về cách chăm sóc và vệ sinh vết mổ. Bên cạnh đó, do NB sinh sống ở vùng nông thôn, khả năng tiếp cận thông tin y tế chính thống còn hạn chế, nên chưa chủ động tìm hiểu hoặc tiếp nhận kiến thức về chăm sóc hậu phẫu một cách đầy đủ.

Vấn đề thứ hai: thiếu kiến thức về chế độ dinh dưỡng phù hợp sau phẫu thuật là yếu tố góp phần ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của NB. NB cho biết gia đình thường ưu tiên sử dụng các thực phẩm rẻ, sẵn có, ít cân đối dinh dưỡng, chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bổ sung các nhóm chất cần thiết để tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ liền vết thương. Ngoài ra, NB chưa từng được tư vấn dinh dưỡng trước và sau phẫu thuật, dẫn đến việc ăn uống thiếu khoa học, đôi khi kiêng khem không hợp lý, gây suy giảm sức khỏe và ảnh hưởng gián tiếp tới vết mổ.

Cây vấn đề cho thấy nguyên nhân gốc rễ của các khó khăn trên là thiếu kiến thức và hạn chế trong tiếp cận thông tin y tế, đặc biệt ở nhóm NB tại khu vực nông thôn. Hệ quả là NB có nguy cơ chăm sóc vết mổ không đúng cách, dễ nhiễm trùng, hồi phục chậm, và sức khỏe tổng thể suy giảm do chế độ dinh dưỡng không phù hợp. Vì vậy, trong kế hoạch can thiệp, học viên CTXH cần ưu tiên hỗ trợ nâng cao kiến thức chăm sóc hậu phẫu cho NB, kết hợp tư vấn về dinh dưỡng và phòng ngừa biến chứng, giúp NB chủ động hơn trong việc tự chăm sóc, phục hồi thể lực và ổn định tinh thần sau xuất viện.

#### *d) Đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng*

Qua quá trình trao đổi, quan sát và tổng hợp kết quả từ các công cụ đánh giá, có thể nhận thấy NB hiện có nhiều nhu cầu hỗ trợ:

NB vừa trải qua phẫu thuật cắt tử cung, thể trạng còn yếu, di chuyển hạn chế và cần thời gian để hồi phục. NB bày tỏ nhu cầu được tư vấn cụ thể về chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm phục hồi sức khỏe, tăng sức đề kháng và phòng ngừa biến chứng. Bên cạnh đó, NB mong muốn được hướng dẫn chi tiết về cách chăm sóc và vệ sinh vết mổ, nhận biết các dấu hiệu bất thường sau phẫu thuật và thực hiện tái khám đúng lịch hẹn để đảm bảo quá trình hồi phục an toàn, hiệu quả.

NB có biểu hiện lo lắng nhẹ liên quan đến khả năng tự chăm sóc bản thân và gánh nặng cho gia đình sau khi xuất viện. Do đó, NB có nhu cầu được chia sẻ, động viên và hỗ trợ tinh thần từ gia đình, nhân viên y tế cũng như nhân viên công tác xã hội. Sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành của những người xung quanh sẽ giúp NB giảm bớt căng thẳng, củng cố niềm tin vào quá trình hồi phục.

Ngoài ra, NB còn có nhu cầu được trang bị kỹ năng chăm sóc bản thân, đặc biệt là các kỹ năng giải tỏa căng thẳng đơn giản, kỹ năng sống và kiến thức tự chăm sóc sức khỏe sau phẫu thuật. NB mong muốn được hướng dẫn cách điều chỉnh sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, phòng ngừa tái phát hoặc biến chứng sau mổ.

#### ***1.4. Một số kỹ năng áp dụng***

Học viên đã vận dụng linh hoạt và phối hợp nhiều kỹ năng trong bước tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng:

- Kỹ năng giao tiếp: Được sử dụng xuyên suốt toàn bộ quá trình làm việc. Học viên đã chủ động thiết lập mối quan hệ tin cậy với NB thông qua thái độ thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng, ngôn ngữ phù hợp và cách đặt câu hỏi mở để khuyến khích NB chia sẻ thông tin.

- Kỹ năng sàng lọc và đánh giá vấn đề tâm lý – xã hội: Thông qua việc khai thác có hệ thống các khía cạnh về thể chất, tinh thần, gia đình, kinh tế, và nguồn lực xã hội. Học viên sử dụng phiếu đánh giá tâm lý – xã hội toàn diện và bộ câu hỏi phỏng vấn sâu giúp thu thập thông tin đa chiều, làm rõ nguyên nhân, biểu hiện và tác động của vấn đề đối với NB.

- Kỹ năng đánh giá môi trường gia đình, văn hóa và kinh tế: Học viên đã sử dụng để xem xét bối cảnh sống, mối quan hệ gia đình, điều kiện sinh hoạt, thu nhập, cũng như quan niệm văn hóa trong việc chăm sóc sức khỏe để đưa ra đánh giá toàn diện và phù hợp thực tế.

- Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ: Học viên đã ghi chép trung thực, rõ ràng và có hệ thống các thông tin thu thập được, bao gồm lời kể của NB, quan sát thực tế và các dữ liệu từ nguồn khác như bác sĩ, người nhà hay hồ sơ bệnh án.

#### **Bước 2: Xây dựng kế hoạch trợ giúp với NB**

Học viên đã xây dựng bảng kế hoạch quản lý trường hợp dành cho NB, trong đó chủ động trao đổi với NB về mức độ tham gia và vai trò của NB trong từng hoạt

động can thiệp, nhằm đảm bảo sự đồng thuận và tính khả thi của kế hoạch. Đồng thời, học viên xin ý kiến của bác sĩ điều trị để thống nhất về nội dung liên quan đến chăm sóc y tế và tiến trình hồi phục của NB, cũng như tham khảo ý kiến của kiểm huấn viên và giảng viên hướng dẫn nhằm rà soát, đánh giá tính phù hợp, hiệu quả và tính thực tiễn của kế hoạch trước khi triển khai.

## KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP

### I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: T.T.T
2. Ngày tháng năm sinh: 1971
3. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ ☐ Khác
4. Người lập kế hoạch: Trần Thị Mai Hương
5. Giảng viên hướng dẫn tại cơ sở: Đoàn Minh Thục
6. Thời gian lập: 18/9/2025

### II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

#### 1. Vấn đề/Nhu cầu hỗ trợ:

- (1) Được hướng dẫn cụ thể về chăm sóc vết mổ và lịch tái khám;
- (2) Được tư vấn về chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm phục hồi thể trạng;
- (3) Được hỗ trợ tâm lý nhằm giảm bớt lo lắng và tăng cường tinh thần tích cực trong quá trình điều trị và phục hồi.

#### 2. Mục tiêu

##### 2.1. Mục tiêu tổng quát

Cung cấp kiến thức y tế và dinh dưỡng chính xác cho NB

##### 2.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: NB được cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc, vệ sinh vết mổ đúng cách

Mục tiêu 2: NB được cung cấp kiến thức về chế độ dinh dưỡng phù hợp

**Bảng 2. Bảng kế hoạch hỗ trợ NB**

| STT | Mục tiêu                                                                                            | Hoạt động                                                                                             | Người tham gia                                    | Nguồn lực               | Thời gian và địa điểm                            | Kinh phí | Kết quả dự kiến                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Mục tiêu 1:</b><br><b>NB được cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc, vệ sinh vết mổ đúng cách</b> | <b>Hoạt động 1:</b> Kết nối với bác sĩ điều trị để cung cấp thông tin về lịch tái khám cho người bệnh | - Học viên CTXH<br>- NB                           | - Bác sĩ điều trị       | 10h00 ngày 22/9/2025 tại phòng bệnh              | Không    | NB được bác sĩ trao đổi, hướng dẫn về tình trạng sức khỏe sau mổ và lịch tái khám, giúp NB an tâm hơn |
|     |                                                                                                     | <b>Hoạt động 2:</b> Kết nối với điều dưỡng để hướng dẫn người bệnh cách chăm sóc, vệ sinh vết mổ      | - Học viên CTXH<br>- NB<br>- Người nhà người bệnh | - Điều dưỡng            | 14h00 ngày 22/9/2025 tại phòng bệnh              | Không    | NB được điều dưỡng hướng dẫn cách chăm sóc và vệ sinh vết mổ tại nhà để tránh bị nhiễm trùng vết mổ   |
| 2   | <b>Mục tiêu 2:</b><br><b>NB được cung cấp kiến thức</b>                                             | <b>Hoạt động 3:</b> Kết nối với chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện để hướng                          | - Học viên CTXH<br>- NB                           | - Chuyên gia dinh dưỡng | 14h00 ngày 23/9/2025 tại phòng tư vấn dinh dưỡng | Không    | NB biết được những loại thực phẩm phù hợp để tăng năng lượng cho cơ thể mà không                      |

| STT | Mục tiêu                                 | Hoạt động                                                                    | Người tham gia | Nguồn lực | Thời gian và địa điểm | Kinh phí | Kết quả dự kiến          |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------------|
|     | <b>thức về chế độ dinh dưỡng phù hợp</b> | dẫn người bệnh về chế độ dinh dưỡng phù hợp hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật |                |           |                       |          | làm ảnh hưởng tới vết mổ |

Trong quá trình xây dựng kế hoạch trợ giúp đối tượng, học viên đã sử dụng kỹ năng lập kế hoạch. Học viên đã tiến hành xác định rõ mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể, dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu và vấn đề ưu tiên của NB. Bên cạnh đó, học viên xác định các hoạt động can thiệp tương ứng, lựa chọn nguồn lực phù hợp (bao gồm NB, gia đình, nhân viên y tế, nhân viên CTXH và cộng đồng) để tham gia hỗ trợ. Trong quá trình này, học viên cũng phân bổ thời gian, nguồn lực và phương thức thực hiện một cách hợp lý, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của NB. Bên cạnh đó học viên đã trao đổi, tham vấn ý kiến của bác sĩ điều trị, kiểm huấn viên và giảng viên hướng dẫn giúp kế hoạch trợ giúp có cơ sở chuyên môn, đồng thời thể hiện sự phối hợp liên ngành và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong công tác xã hội.

### Bước 3. Thực hiện kế hoạch trợ giúp NB

#### 3.1. Tổng hợp các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch

Để triển khai kế hoạch trợ giúp cho NB, học viên đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết bao gồm:

- Sự đồng thuận của NB trong việc tham gia các buổi tư vấn và hướng dẫn chăm sóc.

- Sự phối hợp của đội ngũ y tế, gồm bác sĩ điều trị, điều dưỡng và chuyên gia dinh dưỡng, đảm bảo nội dung tư vấn chính xác, phù hợp với tình trạng hậu phẫu.
- Không gian thực hiện tại phòng bệnh, đảm bảo yên tĩnh, thuận lợi cho việc trao đổi.
- Thời gian sắp xếp hợp lý, tránh trùng với khung giờ thăm khám hoặc chăm sóc y tế để NB có thể tập trung tiếp nhận thông tin.
- Tài liệu hướng dẫn về chăm sóc vết mổ, dinh dưỡng sau mổ và phiếu ghi chép đánh giá được chuẩn bị sẵn để theo dõi tiến trình can thiệp.

### **3.2. Thực hiện kế hoạch trợ giúp NB**

Hoạt động quản lý trường hợp được triển khai qua ba buổi chính, diễn ra từ ngày 22/9/2025 đến 23/9/2025, tập trung vào hai mục tiêu: (1) Hỗ trợ NB được cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc, vệ sinh vết mổ đúng cách, và (2) Hướng dẫn NB chế độ dinh dưỡng phù hợp sau phẫu thuật.

#### **Hoạt động 1: Kết nối với bác sĩ điều trị để cung cấp thông tin về lịch tái khám cho người bệnh**

Học viên CTXH đã chủ động liên hệ và trao đổi trước với bác sĩ điều trị để thống nhất nội dung buổi hướng dẫn. Bác sĩ chia sẻ kế hoạch theo dõi sau mổ gồm ba mốc tái khám (trước khi ra viện, 4–6 tuần và 3–6 tháng) cùng các chỉ số cần kiểm tra như tình trạng vết mổ, tiết dịch, đau, phù nề và chức năng bài tiết.

Buổi trao đổi được tổ chức lúc 10h00 ngày 22/9/2025 tại phòng bệnh. Bác sĩ điều trị trực tiếp giải thích ý nghĩa và mục tiêu của việc tái khám định kỳ, đồng thời hướng dẫn cách tự theo dõi các dấu hiệu bất thường sau mổ (đau tăng, sưng đỏ, chảy dịch, sốt).

Trong buổi làm việc, nhân viên CTXH của khoa tham gia điều phối và hỗ trợ quá trình truyền đạt thông tin giữa bác sĩ và NB, giúp nội dung trở nên dễ hiểu, gần gũi hơn, đồng thời khuyến khích NB đặt câu hỏi nhằm đảm bảo người bệnh nắm rõ nội dung. Học viên CTXH đóng vai trò ghi chép, tổng hợp và phản hồi lại cảm nhận của NB, đồng thời theo dõi phản ứng tâm lý của NB trong quá trình tiếp nhận thông tin. Trong quá trình trao đổi, học viên tiếp nhận thêm thông tin chia sẻ từ bác sĩ rằng NB có thể tái khám tại bệnh viện tỉnh nơi đăng ký BHYT để thuận tiện đi lại và giảm chi phí. Học viên CTXH đã nhắc lại điều này với NB, giúp NB hiểu và yên tâm hơn về việc tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Sau hoạt động, NB thể hiện sự tin tưởng, giảm lo lắng và có thái độ hợp tác tích cực, nắm rõ các mốc tái khám, hiểu được những dấu hiệu cần theo dõi, đồng thời cảm thấy yên tâm hơn khi được biết có thể tái khám tại bệnh viện tuyến tỉnh. Hoạt động này đặt nền tảng vững chắc cho quá trình theo dõi và phục hồi sức khỏe lâu dài của NB sau phẫu thuật.

## **Hoạt động 2: Kết nối với điều dưỡng để hướng dẫn người bệnh cách chăm sóc, vệ sinh vết mổ**

Trước khi triển khai, học viên đã trao đổi trước với nhân viên CTXH của khoa nhằm thống nhất nội dung cần phối hợp với điều dưỡng phụ trách buồng bệnh, đồng thời sắp xếp thời gian thực hiện phù hợp với lịch chăm sóc điều trị của NB. Học viên chuẩn bị sổ ghi chép, bảng hướng dẫn minh họa cách vệ sinh vết mổ, và lên kế hoạch mời người nhà (con gái NB) tham gia buổi hướng dẫn để có thể hỗ trợ NB sau khi xuất viện.

Buổi hướng dẫn được tổ chức lúc 14h00 ngày 22/9/2025 tại phòng bệnh, trong điều kiện đảm bảo vệ sinh và riêng tư cho NB. Điều dưỡng giới thiệu ngắn gọn mục đích buổi hướng dẫn, sau đó trình bày quy trình chăm sóc vết mổ gồm:

- Giữ vết mổ khô, sạch; rửa nhẹ bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ.
- Thay băng hằng ngày hoặc khi bị ướt, bẩn.
- Không chà xát mạnh hoặc dùng dung dịch có cồn, oxy già.
- Quan sát các dấu hiệu cảnh báo (sưng đỏ, tiết dịch, đau nhiều, sốt).

Học viên CTXH thể hiện vai trò hỗ trợ bằng cách quan sát phản ứng của NB và người nhà, kịp thời đặt câu hỏi gợi mở để kiểm tra mức độ hiểu. Học viên cũng sử dụng kỹ năng phản hồi, khuyến khích và thấu cảm, giúp NB cảm thấy yên tâm, không sợ sai khi tự chăm sóc tại nhà. Người nhà NB được mời thực hành lại dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng. Học viên và nhân viên CTXH theo dõi, hỗ trợ khi người nhà thao tác, đảm bảo nắm chắc các bước cơ bản. Trong quá trình hướng dẫn, NB ban đầu còn ngại thực hành do sợ đau và lo vết mổ bị ảnh hưởng, nhưng sau khi được điều dưỡng hướng dẫn nhẹ nhàng và học viên CTXH động viên, NB dần tự tin hơn, sẵn sàng thử thao tác lau rửa nhẹ.

Sau buổi hướng dẫn chăm sóc vết mổ, NB thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe cá nhân. NB đã nắm được các bước cơ bản trong vệ sinh, thay băng và theo dõi dấu hiệu bất thường của vết mổ, đồng thời hiểu rõ hơn

về tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh đúng cách để phòng ngừa nhiễm trùng. Từ tâm lý lo lắng, e ngại ban đầu, NB chuyển sang chủ động và tự tin hơn trong việc tự chăm sóc bản thân, biết cách nhận diện khi nào cần báo nhân viên y tế hoặc tái khám. NB cũng chia sẻ cảm giác yên tâm hơn nhờ được hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu và được thực hành trực tiếp cùng điều dưỡng. Con gái NB đã được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để hỗ trợ mẹ tại nhà, đồng thời hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong quá trình phục hồi của NB.

### **Hoạt động 3: Kết nối với chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện để hướng dẫn người bệnh về chế độ dinh dưỡng phù hợp hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật**

Sau khi NB đã được hướng dẫn về chăm sóc vết mổ và theo dõi sau phẫu thuật, học viên CTXH tiếp tục xác định nhu cầu được tư vấn về chế độ dinh dưỡng phục hồi sức khỏe là ưu tiên thứ hai trong kế hoạch quản lý trường hợp. Học viên đã chủ động trao đổi với kiểm huấn viên để thống nhất cách tiếp cận, đồng thời xin ý kiến bác sĩ điều trị về tình trạng thể chất hiện tại, mức độ hấp thu dinh dưỡng, và các lưu ý đặc biệt sau phẫu thuật cắt tử cung. Trên cơ sở đó, học viên đã kết nối với nhân viên CTXH của Khoa để lập kế hoạch và hỗ trợ kết nối với chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện, sắp xếp thời gian tư vấn phù hợp và chuẩn bị một số câu hỏi giúp NB dễ dàng chia sẻ thói quen ăn uống, sở thích, cũng như những khó khăn trong việc ăn uống sau mổ.

Hoạt động có sự tham gia của chuyên gia dinh dưỡng để cung cấp hướng dẫn chuyên môn về chế độ ăn phục hồi sau phẫu thuật, các nhóm thực phẩm cần ưu tiên và hạn chế, cách chia khẩu phần hợp lý theo thể trạng; bác sĩ điều trị cung cấp thông tin lâm sàng, đánh giá khả năng tiêu hóa, tình trạng hấp thu và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của NB sau mổ; nhân viên CTXH đóng vai trò điều phối buổi tư vấn, đảm bảo thông tin được truyền đạt dễ hiểu, phù hợp với hoàn cảnh xã hội và kinh tế của NB và học viên CTXH thực hiện kỹ năng lắng nghe, ghi chép, quan sát và phản hồi cảm xúc của NB.

Buổi tư vấn được tổ chức lúc 9h00 ngày 23/9/2025 tại phòng tư vấn dinh dưỡng của bệnh viện. Bác sĩ điều trị giới thiệu tóm tắt tình trạng hiện tại của NB cho chuyên viên dinh dưỡng, bao gồm thể trạng yếu, cơ thể suy nhược sau mổ, chưa có biến chứng nhưng cần phục hồi thể lực và sức đề kháng. Chuyên gia dinh dưỡng trao đổi trực tiếp với NB để nắm được thói quen ăn uống trước đây, khẩu vị, khả năng tiêu

hóa và các khó khăn gặp phải sau mổ. Dựa trên đó, chuyên viên hướng dẫn nguyên tắc dinh dưỡng phục hồi: (1) Tăng cường thực phẩm giàu protein dễ tiêu (thịt nạc, cá, trứng, đậu phụ) để tái tạo mô; (2) Bổ sung rau xanh, trái cây tươi giàu vitamin A, C, kẽm nhằm tăng sức đề kháng, hỗ trợ liền vết thương; (3) Uống đủ nước, tránh thức ăn cay nóng, chiên rán, hoặc thực phẩm chế biến sẵn; (4) Ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, giúp tiêu hóa tốt hơn và tránh cảm giác đầy bụng.

Nhân viên CTXH và học viên CTXH hỗ trợ giải thích lại các thuật ngữ chuyên môn, đồng thời giúp NB liên hệ những khuyến nghị này với điều kiện thực tế của gia đình nông thôn (nguồn thực phẩm sẵn có, thu nhập bấp bênh). Học viên gợi ý các lựa chọn phù hợp như: tận dụng nguồn đạm từ trứng gà, cá đồng, rau vườn và trái cây theo mùa. Cuối buổi, học viên CTXH tổng hợp thông tin, nhấn mạnh lại các lưu ý chính và đề xuất NB ghi nhớ lịch tái khám, đồng thời trao đổi thêm về việc duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng ngay cả sau khi xuất viện.

Buổi tư vấn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, thân thiện. NB tỏ ra rất hài lòng, chia sẻ rằng trước đây thường ăn uống qua loa vì sợ ảnh hưởng đến vết mổ, nhưng sau buổi này đã hiểu rõ cách ăn đúng để giúp cơ thể nhanh hồi phục. Thái độ của NB chuyển từ e dè, lo lắng sang tích cực và chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân.

### ***3.3 Kết quả theo dõi diễn biến tâm lý – xã hội của NB***

Trong quá trình can thiệp, học viên CTXH đã tiến hành theo dõi sát sao diễn biến tâm lý – xã hội của NB thông qua các buổi gặp gỡ, phỏng vấn, quan sát và ghi nhận vào phiếu theo dõi. Kết quả cho thấy, NB có nhiều thay đổi tích cực cả về cảm xúc, hành vi và thái độ đối với việc chăm sóc sức khỏe sau phẫu thuật.

- Thời gian: Từ ngày 20/9 đến 27/9/2025 (trong giai đoạn NB nằm viện hậu phẫu).

- Hoạt động hỗ trợ: Ba hoạt động chính được thực hiện bao gồm (1) Kết nối bác sĩ điều trị để xây dựng kế hoạch tái khám, (2) Phối hợp điều dưỡng hướng dẫn chăm sóc vết mổ và theo dõi biến chứng, (3) Tư vấn dinh dưỡng phục hồi sau mổ.

- Diễn biến tâm lý – xã hội:

Giai đoạn đầu: NB có biểu hiện lo lắng, mệt mỏi, phụ thuộc nhiều vào người chăm sóc. Cảm xúc chủ đạo là sợ biến chứng, tự ti vì thể trạng yếu.

Giữa quá trình can thiệp: Sau khi được bác sĩ giải thích rõ lộ trình hồi phục và hướng dẫn cụ thể về vệ sinh vết mổ, NB dần lấy lại sự tự tin, chủ động hơn trong việc

chia sẻ thông tin và thực hành chăm sóc cá nhân. NB bắt đầu thực hiện các động tác nhẹ, đi lại ngắn trong phòng bệnh.

Giai đoạn cuối: Sau buổi tư vấn dinh dưỡng, NB có tinh thần lạc quan hơn, thể hiện mong muốn được xuất viện sớm và tiếp tục tuân thủ hướng dẫn tại nhà. NB hợp tác tốt với nhân viên y tế và bày tỏ sự biết ơn vì được quan tâm, lắng nghe. Tâm trạng ổn định, không còn biểu hiện lo âu hay hoang mang như trước.

- Người phối hợp can thiệp: Bác sĩ điều trị, điều dưỡng phụ trách buồng bệnh, chuyên viên dinh dưỡng, nhân viên CTXH và con gái NB. Mỗi bên tham gia ở từng giai đoạn phù hợp — bác sĩ và điều dưỡng hỗ trợ chuyên môn y tế; nhân viên và học viên CTXH theo dõi tâm lý, kết nối thông tin; người nhà đảm nhiệm chăm sóc tinh thần và hỗ trợ sinh hoạt cơ bản.

- Hoạt động tiếp theo dự kiến: Sau khi xuất viện, học viên CTXH sẽ phối hợp với nhân viên CTXH của bệnh viện tỉnh (nơi NB đăng ký BHYT) để chuyển tiếp thông tin trường hợp, giúp theo dõi việc tái khám, hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc tâm lý lâu dài. Đồng thời, đề xuất nhân viên CTXH tại địa phương duy trì liên lạc định kỳ với NB và người nhà nhằm đảm bảo quá trình phục hồi bền vững và phòng ngừa nguy cơ tái phát.

### **3.4. Kỹ năng đã áp dụng**

Trong quá trình triển khai kế hoạch trợ giúp, học viên công tác xã hội đã linh hoạt phối hợp các kỹ năng hỗ trợ tâm lý và kỹ năng hỗ trợ xã hội, nhằm đáp ứng đồng thời các nhu cầu về thể chất, tinh thần và xã hội của NB.

- Kỹ năng hỗ trợ tâm lý

+ Kỹ năng biện hộ và chuyển gửi: Nhận thấy NB gặp khó khăn trong việc đi tái khám do bảo hiểm y tế trái tuyến, học viên đã vận dụng kỹ năng biện hộ để trao đổi với bác sĩ điều trị và nhân viên CTXH, nhằm đề xuất phương án chuyển gửi thông tin cho bệnh viện tuyến tỉnh – nơi NB đăng ký BHYT. Nhờ vậy, NB có thể thuận tiện hơn trong việc tiếp tục theo dõi sức khỏe mà không phát sinh gánh nặng tài chính. Việc sử dụng kỹ năng biện hộ thể hiện vai trò của học viên trong đảm bảo quyền lợi và tiếp cận dịch vụ y tế công bằng cho NB.

- Kỹ năng hỗ trợ xã hội

(1) Kỹ năng phối hợp liên ngành: thông qua việc kết nối và duy trì sự hợp tác giữa bác sĩ điều trị, điều dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng, nhân viên CTXH và người

nhà NB. Việc điều phối nhịp nhàng giữa các bên giúp các hoạt động triển khai đạt hiệu quả cao, đảm bảo tính toàn diện trong chăm sóc NB.

(2) Kỹ năng vận động và huy động nguồn lực xã hội: Học viên đã khéo léo vận dụng kỹ năng vận động nguồn lực để khuyến khích sự tham gia của người nhà NB trong việc hỗ trợ chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà. Đồng thời, học viên đề xuất nhân viên CTXH bệnh viện tỉnh tiếp nhận thông tin chuyển tiếp để tiếp tục theo dõi NB sau khi xuất viện.

#### **Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp**

Trong giai đoạn theo dõi và lượng giá kết quả can thiệp, học viên CTXH đã sử dụng hai công cụ chính để đánh giá hiệu quả của quá trình hỗ trợ đối với NB sau phẫu thuật cắt tử cung:

(1) Phiếu đánh giá kết quả can thiệp (Phụ lục 1.5): Công cụ này được sử dụng nhằm xác định mức độ cải thiện của NB sau khi thực hiện các hoạt động trong kế hoạch trợ giúp. Phiếu đánh giá được thiết kế với thang điểm 1–5, phản ánh mức độ thay đổi của sáu nhóm vấn đề: sức khỏe thể chất, vấn đề tâm lý, môi trường sống và mối quan hệ gia đình, an toàn sức khỏe, nhu cầu chăm sóc và mối quan hệ xã hội.

(2) Phiếu đánh giá mức độ hài lòng của đối tượng (Phụ lục 1.6): Công cụ này nhằm đo lường mức độ hài lòng và cảm nhận chủ quan của NB đối với hoạt động của nhân viên CTXH, bao gồm các khía cạnh như: khả năng tiếp cận dịch vụ, thái độ hỗ trợ, tính phù hợp của hoạt động, khả năng lắng nghe và giải quyết vấn đề. Phiếu cũng được sử dụng vào cuối giai đoạn can thiệp, khi NB đã trải qua đầy đủ các hoạt động hỗ trợ và có cơ sở để phản hồi trung thực.

#### **Hoạt động 1: Kết nối với bác sĩ điều trị để cung cấp thông tin về lịch tái khám cho người bệnh**

Trước can thiệp: NB còn thiếu kiến thức về việc theo dõi sức khỏe sau phẫu thuật, chưa nắm rõ lịch tái khám và các dấu hiệu bất thường cần báo bác sĩ. NB thể hiện tâm lý lo lắng, e ngại việc quay lại bệnh viện trung ương do quãng đường xa và chi phí đi lại.

Sau can thiệp: NB đã hiểu rõ quy trình tái khám, biết thời điểm và mục tiêu của từng lần kiểm tra sau mổ. Thông qua sự phối hợp giữa học viên CTXH, bác sĩ điều trị và nhân viên CTXH, NB được hướng dẫn có thể tái khám tại bệnh viện tỉnh nơi

đăng ký BHYT để thuận tiện hơn, giúp giảm áp lực tài chính và đi lại. NB bày tỏ sự yên tâm, chủ động ghi nhớ lịch hẹn và chia sẻ lại thông tin cho người nhà.

### **Hoạt động 2: Kết nối với điều dưỡng để hướng dẫn người bệnh cách chăm sóc, vệ sinh vết mổ**

Trước can thiệp: NB chưa được hướng dẫn cụ thể về cách vệ sinh và chăm sóc vết mổ tại nhà; vẫn còn sợ chạm vào vết mổ, e ngại khi thay băng. Người nhà chủ yếu chăm sóc theo kinh nghiệm dân gian (dùng nước muối đậm đặc hoặc oxy già) nên có nguy cơ gây kích ứng da và nhiễm trùng.

Sau can thiệp: Sau khi được điều dưỡng hướng dẫn và học viên CTXH hỗ trợ giải thích lại, NB hiểu rõ cách làm sạch vết mổ bằng nước ấm và xà phòng nhẹ, biết thay băng đúng cách, giữ vùng mổ khô thoáng và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường (sưng, đỏ, tiết dịch). NB chủ động hơn trong việc chăm sóc cá nhân, giảm cảm giác sợ hãi, vết mổ khô đẹp và không có biến chứng. Người nhà cũng biết cách hỗ trợ phù hợp, tránh can thiệp sai cách.

### **Hoạt động 3: Kết nối với chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện để hướng dẫn người bệnh về chế độ dinh dưỡng phù hợp hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật**

Trước can thiệp: NB ăn uống đơn điệu, chủ yếu dùng cơm trắng, rau luộc và cá khô. Gia đình có thói quen tiết kiệm, ít chú ý đến giá trị dinh dưỡng. NB chưa biết các nhóm thực phẩm giúp liền vết thương, tránh viêm nhiễm và phục hồi thể lực.

Sau can thiệp: Sau buổi tư vấn, NB hiểu rõ nguyên tắc ăn đa dạng, đủ đạm – vitamin – khoáng chất, hạn chế đồ chiên rán, tăng rau xanh và trái cây. NB biết lựa chọn thực phẩm dễ tiêu hóa, uống đủ nước, tránh các chất kích thích. Tình trạng ăn uống được cải thiện rõ rệt, sức khỏe phục hồi nhanh hơn, tinh thần lạc quan, ăn ngon miệng và có thể tự chuẩn bị bữa ăn nhẹ. Người nhà cũng tham gia hỗ trợ chế biến và theo dõi khẩu phần.

Kết quả phiếu đánh giá mức độ hài lòng cho thấy NB rất hài lòng (mức 4–5 điểm) với các hoạt động công tác xã hội đã được triển khai. NB cho rằng nhân viên CTXH và học viên luôn quan tâm, lắng nghe, giải thích dễ hiểu, phối hợp kịp thời với bác sĩ và điều dưỡng, giúp NB cảm thấy được tôn trọng và an tâm hơn trong quá trình điều trị.

NB cũng đánh giá cao vai trò của học viên CTXH trong việc hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, dinh dưỡng và giải tỏa căng thẳng, đồng thời giúp NB hiểu rõ quyền lợi

bảo hiểm y tế và hướng dẫn cách chuyển gửi hồ sơ để tái khám tại bệnh viện tuyến tỉnh. Điều này cho thấy mức độ hài lòng không chỉ đến từ kết quả điều trị mà còn từ cảm nhận được sự đồng hành và hỗ trợ nhân văn trong suốt tiến trình can thiệp.

Trong toàn bộ tiến trình triển khai và theo dõi, học viên CTXH đã phát huy tốt kỹ năng phối hợp đa chuyên ngành, tạo nên một mạng lưới hỗ trợ đồng bộ gồm bác sĩ điều trị, điều dưỡng, chuyên viên dinh dưỡng, nhân viên CTXH và người nhà NB. Bác sĩ điều trị đóng vai trò cung cấp chuyên môn, hướng dẫn lộ trình hồi phục và lịch tái khám. Điều dưỡng hướng dẫn NB cách vệ sinh vết mổ, nhận diện dấu hiệu nhiễm trùng và đảm bảo an toàn trong chăm sóc hằng ngày. Chuyên gia dinh dưỡng tư vấn chế độ ăn phục hồi, đảm bảo đủ năng lượng và vi chất cần thiết. Nhân viên và học viên CTXH đóng vai trò trung gian điều phối thông tin, theo dõi tiến triển tâm lý – xã hội, hỗ trợ truyền thông sức khỏe và đảm bảo quyền lợi dịch vụ cho NB. Người nhà NB (đặc biệt là con gái) tham gia tích cực trong việc chăm sóc, lắng nghe hướng dẫn và duy trì các thực hành chăm sóc tại nhà.

Sự phối hợp này không chỉ giúp đảm bảo tính toàn diện trong chăm sóc sức khỏe, mà còn góp phần củng cố niềm tin, giảm lo âu và nâng cao năng lực tự chăm sóc cho NB. Việc kết nối thông tin giữa các thành viên trong nhóm liên ngành diễn ra nhịp nhàng, giúp quá trình lượng giá, điều chỉnh kế hoạch được thực hiện kịp thời và chính xác.

## **Bước 5: Kết thúc quá trình trợ giúp và lưu trữ hồ sơ**

### ***5.1. Kết thúc quá trình trợ giúp***

Sau giai đoạn theo dõi và lượng giá, học viên CTXH cùng nhân viên CTXH phụ trách ca đã tiến hành đánh giá lại toàn bộ tiến trình can thiệp để xác định tình trạng kết thúc trường hợp của NB. Kết quả cho thấy NB đã đạt được hầu hết các mục tiêu trong kế hoạch trợ giúp, cả về mặt thể chất, tâm lý và xã hội.

Cụ thể, NB đã hồi phục tốt sau phẫu thuật, thể trạng ổn định, biết tự chăm sóc và tuân thủ hướng dẫn y tế. Về mặt tâm lý, NB đã chuyển từ trạng thái lo lắng, phụ thuộc sang tự tin, lạc quan và chủ động hơn trong quá trình hồi phục. Các mối quan hệ trong gia đình được cải thiện, người thân hiểu rõ vai trò hỗ trợ, chia sẻ công việc chăm sóc. NB cũng đã được hướng dẫn cụ thể về việc tái khám tại bệnh viện tuyến

tỉnh (nơi đăng ký BHYT), giúp giảm chi phí và thuận lợi hơn cho việc tiếp tục theo dõi sau ra viện.

Dựa trên kết quả lượng giá và sự thống nhất giữa nhóm đa ngành, học viên và nhân viên CTXH xác định trường hợp của NB đủ điều kiện để kết thúc quá trình quản lý trường hợp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bền vững, hồ sơ vẫn được ghi nhận ở dạng “kết thúc tạm thời có theo dõi gián tiếp”, nghĩa là nhân viên CTXH sẽ tiếp tục giữ liên hệ định kỳ qua điện thoại nhằm nắm bắt diễn biến sau ra viện và can thiệp lại khi cần thiết.

Trường hợp này không cần chuyển gửi sang đơn vị khác, do NB đã có nơi cư trú ổn định, có nguồn hỗ trợ từ gia đình, và bệnh viện tuyến tỉnh có thể tiếp tục quản lý tái khám. Việc chuyển giao thông tin được thực hiện qua biên bản tóm tắt trường hợp và hướng dẫn tái khám để bảo đảm tính liên thông giữa hai tuyến dịch vụ.

### **5.2. Lưu trữ hồ sơ**

Sau khi kết thúc quá trình can thiệp, học viên CTXH đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ quản lý trường hợp, bao gồm:

- Hồ sơ hành chính (phiếu thông tin ban đầu, phiếu thu thập dữ liệu, bảng kế hoạch trợ giúp).
- Hồ sơ theo dõi và lượng giá (phiếu theo dõi diễn biến tâm lý – xã hội, phiếu đánh giá kết quả can thiệp, phiếu đánh giá mức độ hài lòng).

Toàn bộ hồ sơ được sắp xếp theo trình tự thời gian và giai đoạn tiến trình quản lý trường hợp, giúp dễ dàng tra cứu, đối chiếu khi cần thiết. Hồ sơ được lưu trữ tại phòng Công tác xã hội của bệnh viện, đồng thời có bản sao điện tử lưu trong hệ thống dữ liệu nội bộ, bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân của NB, chỉ được truy cập bởi nhân viên có thẩm quyền.

### **5.3. Kỹ năng đã áp dụng**

- Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ: Học viên đã vận dụng kỹ năng ghi chép khoa học, khách quan, có hệ thống, thể hiện qua việc tổng hợp đầy đủ tiến trình hỗ trợ, diễn biến của NB và kết quả đạt được so với mục tiêu đặt ra. Việc ghi chép được thực hiện song song với quá trình theo dõi, giúp phản ánh chính xác diễn biến của ca, tránh bỏ sót thông tin. Trong giai đoạn kết thúc, học viên còn thể hiện kỹ năng chọn lọc và tổng hợp thông tin, sắp xếp dữ liệu logic, lập bảng tóm tắt tiến trình can thiệp

và kết quả lượng giá cuối cùng. Hồ sơ được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, đáp ứng yêu cầu quản lý hồ sơ ca bệnh tại bệnh viện.

- Kỹ năng chuyển gửi và kết nối dịch vụ:

Khi đánh giá NB có nhu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe tại tuyến dưới, học viên đã vận dụng kỹ năng chuyển gửi để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ. Học viên chủ động phối hợp với bác sĩ điều trị, nhân viên CTXH bệnh viện và NB nhằm thống nhất phương án tái khám tại bệnh viện tuyến tỉnh. Việc chuyển gửi được thực hiện theo quy trình hai chiều, bao gồm: thông báo cho NB và người nhà về mục đích, quyền lợi, hướng dẫn hồ sơ bảo hiểm y tế; trao đổi với nhân viên CTXH tuyến dưới (nếu có) để cập nhật tình trạng; đồng thời lập phiếu chuyển gửi tóm tắt về thông tin y tế và hỗ trợ tâm lý – xã hội. Qua đó, quá trình can thiệp được đảm bảo tính liên tục, giúp NB không bị gián đoạn trong việc tiếp cận dịch vụ.

## **PHẦN 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP**

### **3.1. Bối cảnh đề xuất giải pháp**

Hoạt động quản lý trường hợp tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được triển khai trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh thực hiện mô hình chăm sóc toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc thực hành quản lý trường hợp vẫn còn gặp nhiều hạn chế về quy trình, nguồn nhân lực và cơ chế phối hợp liên ngành. Nhân viên công tác xã hội tại bệnh viện chủ yếu kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, chưa có hướng dẫn cụ thể cho từng nhóm bệnh lý, trong khi đó sự phối hợp giữa bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên công tác xã hội còn mang tính tự phát, chưa hình thành cơ chế phối hợp chính thức.

Bên cạnh đó, nhận thức của người bệnh và gia đình về vai trò của công tác xã hội còn hạn chế. Họ thường chỉ tìm đến nhân viên công tác xã hội khi có khó khăn tài chính, trong khi các nhu cầu tâm lý – xã hội và phục hồi chức năng sau điều trị chưa được quan tâm đúng mức. Điều này dẫn tới việc quá trình hỗ trợ sau xuất viện còn gián đoạn, ảnh hưởng đến hiệu quả phục hồi và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

### **3.2. Các giải pháp cụ thể**

#### ***Giải pháp 1: Chuẩn hóa quy trình quản lý trường hợp***

Cần xây dựng và áp dụng thống nhất quy trình quản lý trường hợp tại bệnh viện giúp đảm bảo tính hệ thống, chuyên nghiệp và dễ giám sát trong quá trình triển khai. Quy trình này cần bao gồm các bước cụ thể từ tiếp nhận, thu thập thông tin, đánh giá, lập kế hoạch, thực hiện, lượng giá và kết thúc ca, có kèm hướng dẫn sử dụng công cụ đánh giá tâm lý – xã hội toàn diện.

Cơ quan thực hiện: Phòng Công tác xã hội chủ trì, phối hợp với các khoa điều trị/

Thuận lợi: Có nền tảng pháp lý từ Thông tư 43/2015/TT-BYT, Thông tư 51/TT-BYT và kinh nghiệm triển khai các mô hình điểm.

Khó khăn: Thiếu nhân lực được đào tạo bài bản về quản lý trường hợp và hạn chế về thời gian do áp lực công việc trong bệnh viện.

#### ***Giải pháp 2: Nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên công tác xã hội***

Để quản lý trường hợp hiệu quả, nhân viên cần được bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng thu thập thông tin, đánh giá tâm lý – xã hội, lập kế hoạch can thiệp, và kỹ

năng làm việc liên ngành. Bệnh viện cần tổ chức các lớp tập huấn định kỳ, kết hợp mời giảng viên từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành công tác xã hội y tế, đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên tham gia hội thảo, nghiên cứu thực hành.

Cơ quan thực hiện: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phối hợp với các trường đại học có đào tạo công tác xã hội.

Thuận lợi: Có sẵn đội ngũ nhân viên công tác xã hội đang làm việc trong hệ thống bệnh viện.

Khó khăn: Nhân viên khó bố trí thời gian học tập trong khi vẫn phải đảm bảo công tác thường nhật.

### ***Giải pháp 3: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ trường hợp***

Ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ điện tử sẽ giúp theo dõi tiến trình hỗ trợ, lưu trữ dữ liệu an toàn và thuận tiện cho việc đánh giá, báo cáo; giúp nhân viên công tác xã hội kết nối thông tin nhanh với các bộ phận liên quan.

Cơ quan thực hiện: Phòng Công tác xã hội phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin của bệnh viện.

Thuận lợi: Bệnh viện đã có hạ tầng công nghệ tương đối hoàn chỉnh.

Khó khăn: Cần kinh phí đầu tư ban đầu và đào tạo nhân viên sử dụng thành thạo hệ thống.

## KẾT LUẬN

Trải qua 05 tuần thực tập tại Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, học viên đã có cơ hội tham gia trực tiếp vào các hoạt động thường quy của phòng, đồng thời được quan sát, học hỏi và vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trên lớp vào thực tập tiến trình quản lý trường hợp với người bệnh.

Trong thời gian thực tập, học viên đã tìm hiểu về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, chức năng – nhiệm vụ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói chung và Phòng Công tác xã hội nói riêng; đồng thời nắm bắt được các hoạt động hỗ trợ thường xuyên mà phòng triển khai, như tiếp nhận người bệnh khó khăn, truyền thông giáo dục sức khỏe, và quản lý trường hợp. Thông qua đó, học viên nhận thức rõ vai trò trung tâm của người bệnh trong mô hình chăm sóc toàn diện mà bệnh viện đang áp dụng.

Trong quá trình thực tập, học viên đã chủ động tiếp cận và xây dựng mối quan hệ tin tưởng với người bệnh T.T.T, 54 tuổi, quê Ninh Bình, nhập viện điều trị u xơ tử cung và phẫu thuật cắt tử cung tại khoa Phụ Ngoại A5. Sau khi thu thập thông tin, học viên xác định các nhu cầu ưu tiên của người bệnh gồm: cần được hướng dẫn chăm sóc vết mổ, được tư vấn về chế độ dinh dưỡng phục hồi sức khỏe và cần được hỗ trợ tâm lý giảm lo lắng sau phẫu thuật. Từ đó, học viên đã xây dựng kế hoạch quản lý trường hợp với hai mục tiêu cụ thể: (1) Cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc và vệ sinh vết mổ đúng cách; (2) Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp phục hồi thể lực sau phẫu thuật.

Các hoạt động được triển khai trong ba buổi can thiệp, có sự phối hợp giữa học viên công tác xã hội, bác sĩ điều trị, điều dưỡng và chuyên viên dinh dưỡng. Sau khi kết nối với bác sĩ và điều dưỡng, người bệnh đã nắm được cách theo dõi vết mổ, lịch tái khám và các dấu hiệu bất thường cần lưu ý. Trong buổi tư vấn dinh dưỡng, người bệnh được hướng dẫn về nhóm thực phẩm cần bổ sung, cách chế biến món ăn và điều chỉnh khẩu phần phù hợp với thể trạng. Bên cạnh đó, học viên còn trò chuyện, lắng nghe và hỗ trợ tâm lý, giúp người bệnh giảm lo lắng, tăng niềm tin và tinh thần hợp tác trong điều trị.

Kết quả cho thấy, người bệnh đã đạt được những thay đổi tích cực cả về thể chất và tinh thần: sức khỏe ổn định, tinh thần lạc quan hơn, chủ động thực hiện các hướng dẫn chăm sóc bản thân. Người nhà người bệnh cũng được trang bị kiến thức để tham gia hỗ trợ chăm sóc tại nhà.

Đợt thực tập là cơ hội quý báu giúp học viên rèn luyện năng lực nghề nghiệp, đặc biệt là các kỹ năng giao tiếp, thu thập thông tin, đánh giá, lập kế hoạch và phối hợp liên ngành trong môi trường bệnh viện. Qua đó, học viên tích lũy được kinh nghiệm thực tế, củng cố năng lực hành nghề và hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp của một nhân viên công tác xã hội y tế trong tương lai.

Tuy nhiên, trong quá trình thực tập, học viên vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, đặc biệt là kỹ năng thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Do điều kiện thực tế và thời gian can thiệp ngắn, học viên chưa tiếp cận được sâu với bác sĩ điều trị để khai thác thông tin chi tiết về phác đồ và tiên lượng bệnh, dẫn đến việc phân tích vấn đề đôi khi còn mang tính khái quát. Ngoài ra, kỹ năng lượng giá và kỹ thuật ghi chép hồ sơ vẫn cần được hoàn thiện hơn để đảm bảo tính hệ thống và độ tin cậy của dữ liệu. Các kết quả lượng giá vẫn dựa trên những đánh giá chung của người bệnh chứ chưa thật sự đánh giá được hiệu quả thực tế của các hoạt động, đặc biệt là đánh giá về kiến thức của NB sau khi được can thiệp

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 2019 [cited 30 Tháng Mười 2025]. Lịch sử hình thành và phát triển. Available at: <https://benhvienphusanhanoi.vn/lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien/lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-10960.html>
2. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bệnh viện phụ sản. 2025 [cited 30 Tháng Mười 2025]. Sơ đồ tổ chức. Available at: <https://benhvienphusanhanoi.vn/so-do-to-chuc/so-do-to-chuc-10977.html>
3. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bệnh viện phụ sản. 2019 [cited 30 Tháng Mười 2025]. Nhiệm vụ và quyền hạn. Available at: <https://benhvienphusanhanoi.vn/nhiem-vu-va-quyen-han/nhiem-vu-va-quyen-han-10962.html>
4. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bệnh viện phụ sản. 2022 [cited 30 Tháng Mười 2025]. Thành tích đạt được. Available at: <https://benhvienphusanhanoi.vn/hoat-dong-benh-vien/thanh-tich-dat-duoc-102322.html>
5. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bệnh viện phụ sản. 2019 [cited 30 Tháng Mười 2025]. Phòng Công tác xã hội. Available at: <https://benhvienphusanhanoi.vn/phong-cong-tac-xa-hoi/phong-cong-tac-xa-hoi-10980.html>

## PHỤ LỤC

### Phụ lục 1: Các phiếu đánh giá

#### 1.1. Phiếu tiếp nhận và đánh giá ban đầu

**BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI**

**Phòng Công tác xã hội**

**Ngày tiếp nhận: 16/9/2025**

**Mã hồ sơ : QLTH01**

### **PHIẾU TIẾP NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU**

*(Dành cho Nhân viên Công tác xã hội)*

Nhân viên tiếp nhận: Trần Thị Mai Hương

Hình thức tiếp nhận: ☐ Gián tiếp ☒ Trực tiếp

#### **I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Họ và tên: T.T.T

2. Ngày tháng năm sinh: 1971

3. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ ☐

Khác

4. Quê quán: Bắc Lý, Ninh Bình

5. Số điện thoại liên hệ: 093528xxxx

6. Bảo hiểm y tế: ☒ Có ☐ Không Mã số BHYT: GD43701xxxxxxxxx

7. Đối tượng thuộc nhóm nào sau đây? (Ghi chú: có thể 1 đối tượng thuộc một hoặc một số nhóm đối tượng)

- |                                                  |                                                     |                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Trẻ em                  | <input type="checkbox"/> Người cao tuổi             | <input type="checkbox"/> Người khuyết tật  |
| <input type="checkbox"/> Người nghèo             | <input type="checkbox"/> Nạn nhân bị buôn bán       | <input type="checkbox"/> Người có HIV/AIDS |
| <input type="checkbox"/> Nạn nhân bạo lực        | <input type="checkbox"/> Người nghiện ma túy        | <input type="checkbox"/> Người bệnh        |
| <input type="checkbox"/> Người hành nghề mại dâm | <input type="checkbox"/> Người có rối nhiễu tâm trí |                                            |

8. Người thân: N.T.H

Quan hệ: Con gái

Số điện thoại: 098958xxxx

#### **II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU HỖ TRỢ KHẨN CẤP**

| STT | Nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp                                                                  | Có (ghi rõ) | Không |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 1.  | Nơi ở: Đang gặp tình trạng vô gia cư, mất chỗ ở hoặc sống trong điều kiện không an toàn? |             | x     |

|    |                                                                                                        |  |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 2. | Nguy cơ bị bạo lực: Có nguy cơ bị bạo lực thể chất/bạo lực tinh thần/bạo lực tình dục/bạo lực kinh tế? |  | x |
| 3. | Đồ ăn, thức uống: Thiếu đồ ăn, đồ uống hoặc gặp khó khăn trong tiếp cận các nguồn thực phẩm?           |  | x |
| 4. | Tổn thương về thể chất?                                                                                |  | x |
| 5. | Tổn thương về tinh thần: Có nguy cơ tự tử/làm hại bản thân?                                            |  | x |
| 6. | Tổn thương về tâm lý, tình cảm?                                                                        |  | x |
| 7. | Bị cô lập/kỳ thị                                                                                       |  | x |

**Những hành động can thiệp đã được thực hiện đối với đối tượng?**

Chưa có

### III. ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI

#### 1. Kết luận của nhân viên Công tác xã hội:

☐ Hỗ trợ khẩn cấp

☒ Không hỗ trợ khẩn cấp

#### 2. Biện pháp can thiệp khẩn cấp cho đối tượng

| Nhu cầu khẩn cấp của đối tượng | Biện pháp/Dịch vụ cung cấp | Đơn vị thực hiện/cung cấp dịch vụ | Thời gian thực hiện |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                |                            |                                   |                     |

#### 3. Một số giấy tờ tiếp nhận cùng đối tượng

Hồ sơ bệnh án

*Ngày 16 tháng 9 năm 2025*

**Học viên CTXH đánh giá**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Trần Thị Mai Hương

## 1.2. Phiếu đánh giá tâm lý – xã hội toàn diện

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Phòng Công tác xã hội

Ngày tiếp nhận: 17/9/2025

Mã hồ sơ: QLTH01

### PHIẾU ĐÁNH GIÁ TÂM LÝ - XÃ HỘI TOÀN DIỆN

(Dành cho Nhân viên Công tác xã hội sàng lọc)

#### I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: T.T.T

2. Ngày tháng năm sinh: 1971

3. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ ☐

Khác

4. Quê quán: Bắc Lý, Ninh Bình

5. Địa chỉ thường trú: Bắc Lý, Ninh Bình

6. Dân tộc: Kinh

7. Tôn giáo: Không

8. Trình độ học vấn: 12/12

9. Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

10. Nghề nghiệp: Nông dân

11. Số điện thoại liên hệ: 093528xxxx

12. Bảo hiểm y tế: ☒ Có ☐ Không

% được hưởng: 32%

13. Người thân: N.T.H

Quan hệ: Con gái

Số điện thoại: 098958xxxx

14. Nhân viên quản lý trường hợp: Trần Thị Mai Hương

#### II. ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐỐI TƯỢNG GẶP PHẢI

1 Rất khủng hoảng

2 Khủng hoảng

3 Tạm ổn

4 Ổn

5 Rất tốt

| STT | Vấn đề của đối tượng                  | Mức độ đánh giá |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|
| 1.  | Sức khỏe thể chất                     | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.  | Vấn đề tâm lý                         | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.  | Hoàn cảnh gia đình và môi trường sống | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.  | Hành vi sức khỏe và an toàn           | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.  | Nhu cầu chăm sóc                      | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |

|    |                    |   |   |   |   |   |
|----|--------------------|---|---|---|---|---|
| 6. | Mối quan hệ xã hội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|---|---|---|---|---|

## II. THÔNG TIN SỨC KHỎE THỂ CHẤT

### 1. Vấn đề sức khỏe của đối tượng

- NB vừa trải qua phẫu thuật cắt tử cung toàn phần do u xơ tử cung phát triển nhanh.
- Sau mổ, NB còn đau vết mổ, di chuyển hạn chế, cần người hỗ trợ trong vệ sinh cá nhân và thay băng.
- Trước mổ có tiền sử rong kinh kéo dài, dẫn đến thiếu máu nhẹ, cơ thể suy nhược.

### 2. Hướng điều trị dự kiến

- Theo dõi hậu phẫu sát sao để phòng **nhiễm trùng, dính ruột, chảy máu**.
- Hướng dẫn chăm sóc vết mổ, vệ sinh và dinh dưỡng phù hợp.
- Tái khám định kỳ sau 1-2 tuần khi xuất viện.

### 3. Tiên lượng

- Nếu được chăm sóc đúng cách và tuân thủ chế độ dinh dưỡng, khả năng hồi phục tốt.
- Nguy cơ cao xảy ra biến chứng nếu không được theo dõi hoặc thiếu kiến thức chăm sóc hậu phẫu.

## III. THÔNG TIN VẤN ĐỀ TÂM LÝ – SỨC KHỎE TÂM THẦN

### 1. Vấn đề tâm lý của đối tượng

- ☒ Bình thường
- ☐ Căng thẳng (DASS-21): Điểm .....
- ☐ Trầm cảm (DASS-21/PHQ-9/HADS): Điểm.....
- ☐ Rối loạn lo âu (DASS-21/GAD-7/HADS): Điểm.....
- ☐ Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PCL 5): Điểm.....
- ☐ Có ý định tự tử
- ☐ Khác:

### 2. Sức khỏe tâm thần của đối tượng

- ☒ Không có vấn đề ☐ Đang điều trị ☐ Đã điều trị
- ☐ Gia đình có tiền sử bệnh tâm thần ☐ Nghiện chất
- ☐ Khác:

### 3. Trạng thái cảm xúc của đối tượng

- ☐ Bình thường ☐ Thoải mái ☒ Lo lắng

- |                                     |                                  |                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Buồn bã    | <input type="checkbox"/> Đau khổ | <input type="checkbox"/> Sợ hãi |
| <input type="checkbox"/> Giận dữ    | <input type="checkbox"/> Bối rối | <input type="checkbox"/> Cô đơn |
| <input type="checkbox"/> Tuyệt vọng |                                  |                                 |
| <input type="checkbox"/> Khác:      |                                  |                                 |

#### IV. THÔNG TIN VỀ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG

##### 1. Tình trạng nhà ở của đối tượng

- |                                               |                                   |                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nhà riêng | <input type="checkbox"/> Nhà thuê | <input type="checkbox"/> Không có nhà |
| <input type="checkbox"/> Khác:                |                                   |                                       |

##### 2. Gia đình của đối tượng

Số lượng thành viên trong gia đình: 2

Người sống cùng: Hiện NB đang sống cùng với bố đẻ

Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình: Hòa thuận, các con quan tâm nhưng không thể thường xuyên ở nhà chăm sóc do bận công việc.

##### 3. Mức thu nhập trung bình (TB) của gia đình đối tượng

- |                               |                                  |                                                |                                 |                              |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Thấp | <input type="checkbox"/> TB thấp | <input checked="" type="checkbox"/> Trung bình | <input type="checkbox"/> TB cao | <input type="checkbox"/> Cao |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|

##### 4. Người thu nhập chính trong gia đình

- |                                               |                                   |                                |                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Đối tượng | <input type="checkbox"/> Vợ/chồng | <input type="checkbox"/> Bố/mẹ | <input type="checkbox"/> Anh/chị/em |
| <input type="checkbox"/> Khác:                |                                   |                                |                                     |

##### 5. Gia đình thuộc diện chính sách

- |                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Hộ nghèo                     | <input type="checkbox"/> Hộ cận nghèo              |
| <input type="checkbox"/> Gia đình có người khuyết tật | <input type="checkbox"/> Gia đình có người có công |
| <input type="checkbox"/> Khác:                        |                                                    |

##### 6. An ninh trật tự nơi sinh sống

- |                                  |                                                 |                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rất kém | <input type="checkbox"/> Kém                    | <input type="checkbox"/> Bình thường |
| <input type="checkbox"/> An toàn | <input checked="" type="checkbox"/> Rất an toàn |                                      |

##### 7. Các nguồn lực hỗ trợ

- Cộng đồng: Hội phụ nữ thôn sẵn sàng hỗ trợ tinh thần và kết nối khi NB về nhà.

- Chính sách, dịch vụ xã hội: BHYT hộ gia đình thanh toán 32% chi phí điều trị do trái tuyến.

- Nguồn lực khác: Hỗ trợ chăm sóc từ con cái và người thân.

## V. THÔNG TIN VỀ HÀNH VI SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

### 1. Hành vi nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe

- ☐ Nghiện rượu
 ☐ Nghiện chất  
☐ Quan hệ tình dục không an toàn
 ☐ Lạm dụng thuốc  
☐ Không tuân thủ điều trị
 ☐ Hút thuốc lá  
☐ Khác:

## VI. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU HỖ TRỢ

| Nhu cầu hỗ trợ                                                       |                                           | Có (ghi rõ) | Không |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------|
| <b>Hỗ trợ vật chất</b>                                               | Tài chính                                 |             | X     |
|                                                                      | Cung cấp nơi ở                            |             | X     |
| <b>Chăm sóc sức khỏe thể chất</b>                                    | Dinh dưỡng                                | X           |       |
|                                                                      | Khám chữa bệnh/điều trị                   | X           |       |
| <b>Chăm sóc sức khỏe tinh thần</b>                                   | Dịch vụ tham vấn                          |             | X     |
|                                                                      | Dịch vụ giải tỏa căng thẳng, khủng hoảng  |             | X     |
| <b>Chăm sóc tâm lý, tình cảm</b>                                     |                                           | X           |       |
| <b>Kỹ năng chăm sóc bản thân</b>                                     | Kỹ năng giải tỏa căng thẳng               | X           |       |
|                                                                      | Kỹ năng sống                              | X           |       |
|                                                                      | Kỹ năng khác                              | X           |       |
| <b>Nhu cầu đào tạo, dạy nghề</b>                                     | Đi học phổ thông                          |             | X     |
|                                                                      | Đào tạo nghề                              |             | X     |
|                                                                      | Học các khóa chuyên đề nâng cao kiến thức |             | X     |
| <b>Nhu cầu việc làm</b>                                              |                                           |             | X     |
| <b>Nhu cầu hỗ trợ pháp lý</b>                                        |                                           |             | X     |
| <b>Nhu cầu kết nối tới các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của đối tượng</b> |                                           |             | X     |

## VIII. ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI

### 1. Các nguồn lực hỗ trợ:

- Gia đình (con gái lớn, con trai út) sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc và tài chính.

- Nhân viên y tế cung cấp kiến thức chuyên môn về chăm sóc hậu phẫu và dinh dưỡng.
- Cộng đồng có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ tinh thần.
- BHYT hỗ trợ 32% chi phí điều trị.

2. Các vấn đề của đối tượng cần hỗ trợ (ưu tiên):

1. Hướng dẫn chăm sóc vết mổ và phòng ngừa biến chứng hậu phẫu.
2. Tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp để phục hồi sức khỏe.
3. Giảm lo lắng nhẹ thông qua tư vấn tâm lý và cung cấp thông tin chính xác.

3. Dự kiến hậu quả nếu không hỗ trợ kịp thời:

- Nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng hậu phẫu cao, kéo dài thời gian điều trị.
- NB lo lắng tăng, có thể phát triển thành rối loạn lo âu hoặc trầm cảm.
- NB thiếu kiến thức chăm sóc, dẫn đến tái nhập viện và suy giảm sức khỏe lâu dài.

*Ngày 17 tháng 9 năm 2025*

**Học viên CTXH đánh giá**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Trần Thị Mai Hương

### ***1.3. Bảng kế hoạch hỗ trợ người bệnh***

**BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI**

**Mã hồ sơ: QLTH01**

**Phòng Công tác xã hội**

## **KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP**

*(Dành cho Nhân viên Công tác xã hội)*

### **I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Họ và tên: T.T.T

2. Ngày tháng năm sinh: 1971

3. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ ☐

4. Người lập kế hoạch: CN. Trần Thị Mai Hương

5. Giảng viên hướng dẫn tại cơ sở: ThS. Đoàn Minh Thục

6. Thời gian lập: 18/9/2025

### **II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

#### ***1. Vấn đề/Nhu cầu hỗ trợ:***

- (1) Được hướng dẫn cụ thể về chăm sóc vết mổ và lịch tái khám;
- (2) Được tư vấn về chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm phục hồi thể trạng;
- (3) Được hỗ trợ tâm lý nhằm giảm bớt lo lắng và tăng cường tinh thần tích cực trong quá trình điều trị và phục hồi.

#### ***2. Mục tiêu***

##### ***2.1. Mục tiêu tổng quát***

Cung cấp kiến thức y tế và dinh dưỡng chính xác cho NB

##### ***2.2. Mục tiêu cụ thể***

Mục tiêu 1: NB được cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc, vệ sinh vết mổ đúng cách

Mục tiêu 2: NB được cung cấp kiến thức về chế độ dinh dưỡng phù hợp

#### ***3. Bảng kế hoạch quản lý trường hợp***

| STT | Mục tiêu                                                                                            | Hoạt động                                                                                                                             | Người tham gia                                    | Nguồn lực               | Thời gian và địa điểm                            | Kinh phí | Kết quả dự kiến                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Mục tiêu 1:</b><br><b>NB được cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc, vệ sinh vết mổ đúng cách</b> | <b>Hoạt động 1:</b> Kết nối với bác sĩ điều trị để cung cấp thông tin về lịch tái khám cho người bệnh                                 | - Học viên CTXH<br>- NB                           | - Bác sĩ điều trị       | 10h00 ngày 22/9/2025 tại phòng bệnh              | Không    | NB được bác sĩ trao đổi, hướng dẫn về tình trạng sức khỏe sau mổ và lịch tái khám, giúp NB an tâm hơn     |
|     |                                                                                                     | <b>Hoạt động 2:</b> Kết nối với điều dưỡng để hướng dẫn người bệnh cách chăm sóc, vệ sinh vết mổ                                      | - Học viên CTXH<br>- NB<br>- Người nhà người bệnh | - Điều dưỡng            | 14h00 ngày 22/9/2025 tại phòng bệnh              | Không    | NB được điều dưỡng hướng dẫn cách chăm sóc và vệ sinh vết mổ tại nhà để tránh bị nhiễm trùng vết mổ       |
| 2   | <b>Mục tiêu 2:</b><br><b>NB được cung cấp kiến thức về chế độ dinh dưỡng phù hợp</b>                | <b>Hoạt động 3:</b> Kết nối với chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện để hướng dẫn người bệnh về chế độ dinh dưỡng phù hợp hồi phục sức | - Học viên CTXH<br>- NB                           | - Chuyên gia dinh dưỡng | 14h00 ngày 23/9/2025 tại phòng tư vấn dinh dưỡng | Không    | NB biết được những loại thực phẩm phù hợp để tăng năng lượng cho cơ thể mà không làm ảnh hưởng tới vết mổ |

| STT | Mục tiêu | Hoạt động           | Người tham gia | Nguồn lực | Thời gian và địa điểm | Kinh phí | Kết quả dự kiến |
|-----|----------|---------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|
|     |          | khỏe sau phẫu thuật |                |           |                       |          |                 |

**Đối tượng**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Lãnh đạo đơn vị**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Ngày.....tháng.....năm.....*

**Người lập kế hoạch**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Trần Thị Mai Hương**

#### 1.4. Phiếu theo dõi diễn biến tâm lý – xã hội

**BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI**  
**Phòng Công tác xã hội**

**Mã hồ sơ: QLTH01**

### **PHIẾU THEO DÕI DIỄN BIẾN TÂM LÝ - XÃ HỘI**

*(Dành cho Nhân viên Công tác xã hội)*

#### **I. THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG**

1. Họ và tên: T.T.T

2. Ngày tháng năm sinh: 1971

3. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ ☐

4. Nhân viên quản lý trường hợp: Trần Thị Mai Hương

#### **II. MỤC TIÊU HỖ TRỢ TÂM LÝ – XÃ HỘI**

Mục tiêu 1: NB được cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc, vệ sinh vết mổ đúng cách

Mục tiêu 2: NB được cung cấp kiến thức về chế độ dinh dưỡng phù hợp

#### **III. DIỄN BIẾN TÂM LÝ – XÃ HỘI**

| Thời gian          | Hoạt động hỗ trợ                                        | Diễn biến tâm lý – xã hội đối tượng                                               |                                                                   | Người phối hợp can thiệp                      | Hoạt động tiếp theo dự kiến                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         | Tích cực                                                                          | Tiêu cực                                                          |                                               |                                                                     |
| 20/9–<br>22/9/2025 | Kết nối bác sĩ điều trị để thống nhất kế hoạch tái khám | Sau hướng dẫn, NB hiểu rõ lịch tái khám, yên tâm hơn, chủ động ghi nhớ thông tin. | NB lo lắng, mệt mỏi, sợ biến chứng, phụ thuộc vào người chăm sóc. | Bác sĩ điều trị, nhân viên CTXH               | Theo dõi việc thực hiện lịch tái khám và hỗ trợ kết nối tuyến tính. |
| 23/9–<br>25/9/2025 | Phối hợp điều dưỡng hướng dẫn vệ sinh,                  | Sau hướng dẫn, NB tự tin vệ sinh vết mổ, vết thương khô, không biến               | Ban đầu NB e ngại, sợ chạm vào vết mổ, chưa biết cách thay băng.  | Điều dưỡng phụ trách buồng bệnh, người nhà NB | Tiếp tục theo dõi việc chăm sóc tại nhà                             |

|                    |                                                    |                                                                                                                                                           |  |                                                |                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | chăm sóc vết<br>mổ                                 | chúng, người<br>nhà phối hợp<br>tốt.                                                                                                                      |  |                                                | sau xuất<br>viện.                                                                   |
| 26/9–<br>27/9/2025 | Tư vấn dinh<br>dưỡng phục<br>hồi sau phẫu<br>thuật | NB vui vẻ, lạc<br>quan, chủ động<br>áp dụng chế độ<br>ăn phù hợp, biết<br>lựa chọn thực<br>phẩm giàu dinh<br>dưỡng, hợp tác<br>tốt với nhân<br>viên y tế. |  | Chuyên viên<br>dinh dưỡng,<br>học viên<br>CTXH | Chuyển<br>tiếp hồ sơ<br>cho nhân<br>viên CTXH<br>tuyển tỉnh<br>theo dõi dài<br>hạn. |

*Ngày 27 tháng 9 năm 2025*

**Học viên CTXH đánh giá**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Trần Thị Mai Hương

**1.5. Phiếu đánh giá kết quả can thiệp**

**BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI**

**Phòng Công tác xã hội**

**Ngày đánh giá: 27/9/2025**

**Mã hồ sơ: QLTH01**

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP**

*(Dành cho Nhân viên Công tác xã hội)*

**I. THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG**

1. Họ và tên: T.T.T

2. Ngày tháng năm sinh: 1971

3. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ ☐

4. Ngày đánh giá: 27/9/2025

**II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VẤN ĐỀ CỦA ĐỐI TƯỢNG**

1 Rất khủng hoảng

2 Khủng hoảng

3 Tạm ổn

4 Ổn

5 Rất tốt

| STT | Vấn đề của đối tượng                  | Mức độ đánh giá |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|
| 1.  | Sức khỏe thể chất                     | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.  | Vấn đề tâm lý                         | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.  | Hoàn cảnh gia đình và môi trường sống | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.  | Hành vi sức khỏe và an toàn           | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.  | Nhu cầu chăm sóc                      | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.  | Mối quan hệ xã hội                    | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |

**III. KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP**

Sau quá trình can thiệp, NB có tiến triển rõ rệt: sức khỏe hồi phục, tinh thần ổn định, hiểu rõ quy trình tái khám và thực hiện tốt hướng dẫn chăm sóc. NB chủ động chia sẻ cảm xúc, hợp tác với nhân viên y tế, tích cực thực hiện chế độ dinh dưỡng. NB đánh giá rất hài lòng (4–5 điểm) với hoạt động công tác xã hội, đặc biệt ghi nhận sự hỗ trợ tận tình, khả năng lắng nghe và phối hợp hiệu quả của học viên CTXH với bác sĩ, điều dưỡng và chuyên viên dinh dưỡng. Sự phối hợp đa chuyên ngành giúp NB giảm lo âu, tăng năng lực tự chăm sóc và cảm nhận được sự quan tâm nhân văn trong suốt quá trình điều trị.

*Ngày 27 tháng 9 năm 2025*

Trần Thị Mai Hương

1.6. Phiếu đánh giá mức độ hài lòng của đối tượng

**BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI**  
Phòng Công tác xã hội

Ngày đánh giá: 27/9/2025  
Mã hồ sơ: QLTH01

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI HOẠT ĐỘNG**  
(Dành cho Đối tượng)

**I. THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG**

1. Họ và tên: T.T.T  
2. Ngày tháng năm sinh: 1971  
3. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ  
4. Ngày đánh giá: 27/9/2025

**Mức độ đánh giá:**

- 1 Rất không hài lòng      2 Không hài lòng      3 Bình thường  
4 Hài lòng      5 Rất hài lòng

| STT | Nội dung đánh giá                                                                 | Mức độ đánh giá |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|
| 1.  | Ông/bà có hài lòng về hoạt động Công tác xã hội (CTXH) không?                     | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.  | Nhân viên CTXH hiểu và hỗ trợ tiếp cận đầy đủ, kịp thời nhu cầu của ông/bà?       | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.  | Sự hỗ trợ của nhân viên CTXH đã giúp ông/bà giải quyết vấn đề tâm lý – xã hội?    | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.  | Ông/bà đánh giá như thế nào về kỹ năng của nhân viên CTXH trong quá trình hỗ trợ? | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.  | Các hoạt động hỗ trợ phù hợp với sức khỏe thể chất, tinh thần của ông/bà?         | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.  | Ông/bà có sẵn sàng giới thiệu nhân viên CTXH tới những đối tượng khác cần hỗ trợ? | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng hoạt động Công tác xã hội?

**Người đánh giá**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



## Phụ lục 2: Phức trình ca

### Phụ lục 2.1. Phức trình buổi 1

- Thông tin cá nhân của đối tượng: T.T.T
- Địa điểm thực hiện phức trình: Phòng bệnh
- Thời gian thực hiện phức trình: 9h00 – 9h30 ngày 16/9/2025
- Phức trình lần thứ: 1
- Mục tiêu buổi làm việc: Tiếp cận và tạo lập mối quan hệ với NB
- Người thực hiện: Trần Thị Mai Hương

| Mô tả nội dung phức trình                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cảm xúc & hành vi của NB                                    | Tự đánh giá cảm xúc của HV                                              | Tự đánh giá kỹ năng, kỹ thuật sử dụng |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>HV:</b> “Chào cô, cháu là Hương – học viên thạc sĩ Công tác xã hội của Trường Đại học Y tế công cộng. Hôm nay cháu được bệnh viện phân công tới thăm hỏi và hỗ trợ cô trong thời gian cô đang điều trị tại khoa. Không biết bây giờ cô có tiện để cháu ngồi nói chuyện cùng cô một lúc không ạ?” | NB hơi bất ngờ, ngược nhìn nhưng nét mặt còn mệt và dè dặt. | Hơi lo lắng xem NB có hợp tác không, nhưng vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng. | Sử dụng kỹ năng giao tiếp             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ĐT:</b> “Ừ... cô cũng đang hơi mệt nhưng cháu cứ ngồi xuống đi.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giọng nhỏ, nét mặt còn căng thẳng, tay giữ bụng mổ.                                                                                                         | Cảm thấy NB đang trong trạng thái lo lắng nhẹ, cần điều chỉnh tốc độ nói. | Kỹ năng lắng nghe, quan sát           |
| <b>HV:</b> “Dạ, cháu cảm ơn cô. Trước tiên cháu muốn giới thiệu rõ hơn một chút: cháu là học viên CTXH tới đây với mong muốn được lắng nghe chia sẻ của cô và hỗ trợ cô kết nối với các nguồn lực phù hợp. Những thông tin cô chia sẻ sẽ được giữ bí mật, chỉ dùng cho mục đích hỗ trợ điều trị và sẽ không cung cấp cho ai khác khi chưa có sự đồng ý của cô. Cháu nói vậy để cô yên tâm khi trao đổi với cháu ạ.” | NB nhìn học viên kỹ hơn, gật đầu nhẹ. Dáng vẻ thư giãn hơn lúc đầu.<br>“Ừ, thế thì cô yên tâm hơn. Cô cũng không biết phải hỏi ai, nhiều khi cũng lo lắng.” | Cảm thấy dễ chịu hơn khi NB tiếp nhận thông tin và hợp tác.               | Kỹ năng giao tiếp, cung cấp thông tin |
| <b>HV:</b> Cô có thể cho cháu xin họ tên, tuổi và quê quán của mình ạ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>NB:</b> Cô tên là T.T.T, năm nay 54 tuổi, cô ở Ninh Bình cũ                                                                                              |                                                                           | Kỹ năng đặt câu hỏi                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>HV:</b> Cô đã nhập viện từ hôm nào rồi ạ?                                                                                                                                                                                                     | <b>NB:</b> Cô nhập viện hôm 11/9 xong rồi bác sĩ có chỉ định cho đi mổ luôn ngày hôm sau là 12/9.                                                 |                                                            | Kỹ năng đặt câu hỏi                            |
| <b>HV:</b> Nguyên nhân vì sao cô lại phải phẫu thuật thế ạ?                                                                                                                                                                                      | <b>NB:</b> Cô mổ cắt tử cung vì u xơ ở tử cung to quá. Vấn đề này cũng nhạy cảm nên cô chả muốn chia sẻ với ai                                    |                                                            | Kỹ năng đặt câu hỏi                            |
| <b>HV:</b> “Dạ, cô cứ yên tâm ạ. Hôm nay cháu đến chủ yếu để làm quen và tìm hiểu xem cô đang gặp khó khăn gì, sức khỏe sau mổ thế nào, để cháu xem có thể hỗ trợ gì cho cô. Cô có thể chia sẻ cho cháu biết hiện cô đang thấy thế nào không ạ?” | NB thở dài, đặt tay lên bụng mổ: “Cô còn đau nhiều, di chuyển cũng khó... Ban đêm ngủ không được, cứ lo lắng... sợ bị biến chứng, sợ hồi phục lâu | Cảm giác thương và đồng cảm, cố giữ thái độ chuyên nghiệp. | Kỹ năng đặt câu hỏi                            |
| <b>HV:</b> “Dạ cháu hiểu, phẫu thuật lớn nên cô thấy đau và lo lắng là hoàn toàn bình thường.                                                                                                                                                    | NB hơi rung rung, nhìn xuống sàn; giọng chậm lại “Cô lo nhất là không biết sau này                                                                |                                                            | Kỹ năng thấu cảm; lắng nghe tích cực, quan sát |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Những điều cô nói cho thấy cô đang chịu nhiều áp lực. Theo cô, điều gì làm cô lo nhất lúc này?”       | có tự chăm được không. Ở nhà cô làm hết mọi việc. Giờ mổ xong, nghĩ đến lúc về nhà mà không nhắc nổi người là cô lại sợ”                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                |
| <b>HV:</b> “Nếu cô được chọn 1–2 điều cô muốn được hỗ trợ nhất lúc này, cô mong muốn điều gì nhất ạ?” | NB mở lòng nhiều hơn, giao tiếp bằng mắt nhiều hơn<br>“Cô muốn có người chỉ cho cách chăm vết mổ. Cô sợ làm sai. Với ăn uống nữa. Giờ chẳng biết nên kiêng gì, ăn gì. Cô cũng muốn có người để nói chuyện, chia sẻ. Chứ nhiều khi nghĩ nhiều quá. Nếu tốt hơn thì cô cũng muốn biết lịch tái khám cho rõ... Nếu tái khám gần nhà thì đỡ vất vả.” |                                      | Kỹ năng giao tiếp, đặt câu hỏi |
| <b>HV:</b> “Nếu cô đồng ý, những buổi sau cháu sẽ hỏi cô thêm về quá trình điều trị, sinh hoạt, dinh  | NB: “Ừ, cô đồng ý.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tự tin hơn vào nhip làm việc với NB. | Kỹ năng giao tiếp, đặt câu hỏi |

|                                                                                                                                                                        |                     |  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| duỡng và tình thần của cô, để cháu hỗ trợ cô tốt hơn. Điều này cô thấy ổn chứ ạ?”                                                                                      |                     |  |                             |
| HV: Dạ vâng, vậy cháu xin phép sẽ gặp cô trong buổi tiếp theo để tìm hiểu kỹ hơn về các thông tin liên quan đến vấn đề để cô và cháu cùng tìm hướng giải quyết cô nhé! | NB: “Ừ, cô đồng ý.” |  | Kỹ năng giao tiếp, phản hồi |

### **Kết quả của phúc trình**

- NB hợp tác tốt, cởi mở và tin tưởng HV.
- NB chủ động chia sẻ về các vấn đề khó khăn và nhu cầu mong muốn được hỗ trợ
- Môi quan hệ ban đầu được thiết lập; NB tin tưởng và hợp tác cho các buổi sau.

### **Phụ lục 2.2. Phúc trình buổi 2**

- Thông tin cá nhân của đối tượng: T.T.T
- Địa điểm thực hiện phúc trình: Phòng bệnh
- Thời gian thực hiện phúc trình: 9h00 – 9h30 ngày 17/9/2025
- Phúc trình lần thứ: 2
- Mục tiêu buổi làm việc: Thu thập thông tin của NB
- Người thực hiện: Trần Thị Mai Hương

| <b>Mô tả nội dung phúc trình</b> | <b>Cảm xúc &amp; hành vi của NB</b> | <b>Tự đánh giá cảm xúc của HV</b> | <b>Tự đánh giá kỹ năng, kỹ thuật sử dụng</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p><b>HV:</b> “Cô ơi, hôm nay cháu xin phép được trao đổi kỹ hơn với cô để hiểu về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, sinh hoạt của cô... Những thông tin này giúp cháu xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp nhất với cô. Cháu xin phép ghi chép lại trong lúc mình nói chuyện, cô nhé”</p> | <p><b>NB:</b> Ủ, cháu cứ hỏi đi. Cô chia sẻ được đến đâu thì chia sẻ.</p>                                                                                                                                    | <p>Cảm thấy thoải mái vì NB hợp tác tốt</p> | <p>Kỹ năng giao tiếp</p>                                 |
| <p>Cô cảm thấy cơ thể mình hôm nay thế nào rồi ạ?</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>Cô vẫn còn đau chỗ vết mổ, nhất là lúc đứng dậy. Nhưng so với hôm trước thì đỡ hơn. Đi lại vẫn rất hạn chế, cô phải vịn giường mới đứng lên được. Cô cũng sợ đau nên nhiều lúc không dám cử động mạnh</p> |                                             | <p>Kỹ năng đặt câu hỏi, sàng lọc, đánh giá thông tin</p> |
| <p>Cô có thể kể cho cháu nghe về việc ăn uống mấy hôm nay không ạ?</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>Cô ăn ít lắm. Nuốt được nhưng không thấy ngon miệng. Cô nghe người ta bảo mổ thì phải</p>                                                                                                                 |                                             | <p>Kỹ năng đặt câu hỏi, sàng lọc, đánh giá thông tin</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |  |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kiêng đủ thứ, mà thật ra cô cũng không chắc phải kiêng gì.                        |  |                                                              |
| Còn sinh hoạt hàng ngày thì sao ạ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cô phải nhờ con gái giúp tắm rửa, thay băng. Đêm thì khó ngủ, cứ lăn qua lăn lại. |  | Kỹ năng đặt câu hỏi, sàng lọc, đánh giá thông tin            |
| Như vậy là hiện tại sau khi phẫu thuật xong do vẫn còn đau ở vết mổ nên cô gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra là vì cô chưa biết chế độ dinh dưỡng phù hợp nên cũng chưa thể biết mình nên ăn gì cho khỏe. Hôm trước cháu cũng được cô trao đổi về nhu cầu được hỗ trợ về vấn đề tự chăm sóc cho bản thân sau khi xuất viện | Ừ đúng rồi, cô lo lắm vì ở có 1 mình với bố già. Các con thì đều ở xa             |  | Kỹ năng đặt câu hỏi, lắng nghe, sàng lọc, đánh giá thông tin |
| Cô có thể chia sẻ cho cháu về gia đình mình – những                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cô sống với bố già, ông yếu lắm. Cô chăm ông là chính.                            |  | Kỹ năng đặt câu hỏi, sàng lọc, đánh giá thông tin            |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |  |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| ai đang sống cùng cô ạ?                                                                                                       | Hai con gái lập gia đình rồi, cũng gần nhà nhưng bận rộn. Con trai út thì chưa có việc ổn định, cũng không khéo chăm sóc người ốm.                                |  |                                                   |
| Còn điều kiện sống ở nhà mình thì sao ạ?                                                                                      | Nhà cô ở nông thôn, cũng thoáng, sạch. Nhà cô thì gần bệnh viện tỉnh, tầm 15 km là tới. Còn đi lên Hà Nội để thăm khám như này xa quá, nên cô sợ tái khám nhiều.” |  | Kỹ năng đặt câu hỏi, sàng lọc, đánh giá thông tin |
| Dạ vâng, theo như chia sẻ của cô thì cháu hiểu cô cũng đang có sự lo lắng về việc sẽ phải đi tái khám ở tại đây đúng không ạ? | Ừ                                                                                                                                                                 |  | Kỹ năng đặt câu hỏi, lắng nghe, phản hồi          |
| Cô đã từng được nghe bác sĩ trao đổi các thông tin liên quan đến việc tái khám của mình sau khi mổ chưa ạ                     | Cô chưa vì hôm đấy nhập viện xong cũng đi mỗ luôn. Nếu có chắc bác sĩ giải thích qua với con gái cô                                                               |  | Kỹ năng đặt câu hỏi, sàng lọc, đánh giá thông tin |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| Dạ vâng. Vậy thì khi biết mình bị u xơ tử cung, cô đã đối diện và xử lý như thế nào ạ?                                                              | Ban đầu cô sốc lắm... nhưng rồi cô nghĩ cố gắng nghe bác sĩ. Bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung nên cô cũng hơi lo lắng. Bác sĩ với các con cũng động viên ở độ tuổi này rồi, cũng đã đầy đủ con cái thì nên phẫu thuật để đảm bảo sức khỏe. Cô luôn tự trấn an mình: mổ để khỏe hơn. |  | Kỹ năng đặt câu hỏi, sàng lọc, đánh giá thông tin |
| Trong thời gian tới, cháu sẽ có vài hoạt động hỗ trợ cô: hướng dẫn chăm sóc vết mổ, tư vấn dinh dưỡng... Cô cảm thấy mình có tham gia được không ạ? | Cô tham gia được. Cô cũng muốn biết đầy đủ để sau về nhà còn chủ động. Cô chỉ lo là ngồi lâu thì mệt, nhưng nói chuyện được. Nếu cần thực hành gì thì có thể để con gái cô làm cùng.”                                                                                                                  |  | Kỹ năng đặt câu hỏi, sàng lọc, đánh giá thông tin |
| Dạ, cô cứ yên tâm ạ. Cháu sẽ lựa chọn những hoạt động hỗ                                                                                            | Vậy thì cô yên tâm quá rồi. Cảm ơn cháu nhé                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Kỹ năng phản hồi                                  |

|                                                                                                             |                     |  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| trợ phù hợp với nhu cầu hỗ trợ của cô, đồng thời cũng phù hợp với thể trạng của cô ạ!                       |                     |  |                             |
| HV: Dạ vâng, vậy cháu xin phép trong các buổi tiếp theo sẽ cùng cô tham gia các hoạt động hỗ trợ phù hợp ạ. | NB: “Ừ, cô đồng ý.” |  | Kỹ năng giao tiếp, phản hồi |

***Phụ lục 2.3. Phức trình buổi 3***

- Thông tin cá nhân của đối tượng: T.T.T
- Địa điểm thực hiện phức trình: Phòng bệnh
- Thời gian thực hiện phức trình: 9h00 – 9h30 ngày 18/9/2025
- Phức trình lần thứ: 3
- Mục tiêu buổi làm việc: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ NB
- Người thực hiện: Trần Thị Mai Hương

| <b>Mô tả nội dung phức trình</b>                                                                                                                               | <b>Cảm xúc &amp; hành vi của NB</b>                                              | <b>Tự đánh giá cảm xúc của HV</b> | <b>Tự đánh giá kỹ năng, kỹ thuật sử dụng</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Hôm nay cháu muốn trao đổi với cô về kế hoạch hỗ trợ trong những ngày tới. Kế hoạch này dựa trên những thông tin cô đã chia sẻ ở buổi trước và nhu cầu của cô. | Ừ, cô cũng muốn biết xem sắp tới mình sẽ làm những gì để còn chuẩn bị tinh thần. |                                   | Kỹ năng giao tiếp                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |  |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| Cháu xin phép trình bày, cô cho cháu biết cảm nhận và mong muốn của mình, được không ạ?                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |  |                                                              |
| Hoạt động đầu tiên là kết nối với bác sĩ điều trị để cung cấp cho cô thông tin chi tiết về lịch tái khám. Cháu nhớ cô lo lắng về việc không biết khi nào cần tái khám và có phải lên Hà Nội nhiều không. Hoạt động này sẽ thực hiện lúc 10h ngày 22/9. Cô thấy thế nào ạ? | Cô thấy rất cần đấy. Cô lo nhất là chuyện tái khám. Nếu bác sĩ nói rõ cho cô thì cô sẽ yên tâm hơn. Cô muốn hỏi bác sĩ cách theo dõi vết mổ nữa. |  | Kỹ năng đặt câu hỏi, sàng lọc, đánh giá thông tin            |
| Dạ, những câu hỏi đó rất quan trọng. Cháu sẽ hỗ trợ cô ghi lại và nhờ bác sĩ giải đáp đầy đủ.”                                                                                                                                                                            | NB nghiêng người về phía HV, thể hiện sự quan tâm; ánh mắt yên tâm hơn                                                                           |  | Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ, kỹ năng xây dựng kế hoạch |
| Hoạt động thứ hai là kết nối với điều dưỡng để hướng dẫn cô cách chăm sóc và vệ sinh vết                                                                                                                                                                                  | Rất phù hợp luôn. Cô sợ nhất là về nhà không biết xử lý thế nào. Con gái cô cũng muốn học                                                        |  | Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ, kỹ năng xây dựng kế hoạch |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |  |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| mổ. Hoạt động này sẽ có sự phối hợp của người nhà cô để sau khi xuất viện, cả nhà đều biết cách chăm sóc. Buổi này dự kiến lúc 14h ngày 22/9. Cô có thấy phù hợp không ạ?                                                                                   | cách chăm vết mổ cho chuẩn. Cháu cho nó tham gia với nhé.                                                                                |  |                                                              |
| Dạ có cô ạ, cháu đã đưa người nhà vào kế hoạch rồi. Điều dưỡng sẽ hướng dẫn cả cô và con gái cô ạ.                                                                                                                                                          | NB gặt đầu liên tục, vẽ nhẹ nhõm                                                                                                         |  | Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ, kỹ năng xây dựng kế hoạch |
| Cô từng chia sẻ rằng cô rất băn khoăn không biết phải ăn gì sau phẫu thuật. Vì vậy hoạt động thứ ba là kết nối chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện để tư vấn cho cô một chế độ ăn phù hợp để hồi phục tốt hơn. Buổi tư vấn sẽ diễn ra lúc 14h ngày 23/9 tại | Ôi hoạt động này cô cần lắm. Cô ăn uống kiêng khem tùy cảm tính, sợ ảnh hưởng đến vết mổ. Nếu có chuyên gia hướng dẫn thì cô yên tâm hơn |  | Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ, kỹ năng xây dựng kế hoạch |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| phòng tư vấn dinh dưỡng.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |  |                                                              |
| Dạ, buổi tư vấn sẽ giúp cô biết rõ loại thực phẩm nào tốt cho hồi phục và những loại nên hạn chế                                                                                   | Thế thì hay và tốt quá nhưng cô có phải di chuyển nhiều không cháu?                                                                                                                          |  | Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ, kỹ năng xây dựng kế hoạch |
| Dạ cháu sẽ trao đổi và hẹn lịch với chuyên gia dinh dưỡng. Sau đó cô và cháu sẽ cùng di chuyển tới phòng tư vấn dinh dưỡng của bệnh viện ạ. Cũng không phải đi lại quá nhiều đâu ạ | Ừ. Tại cô sợ vẫn còn đau vết mổ ấy. Nếu được cháu sắp xếp giúp cô nhé                                                                                                                        |  | Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ, kỹ năng xây dựng kế hoạch |
| Vâng ạ. Sau khi nghe các hoạt động, cô có muốn điều chỉnh gì không? Hoặc cô có thêm nhu cầu nào mới không ạ?                                                                       | Không cần chỉnh gì đâu cháu. Ba hoạt động đều đúng với những điều cô lo lắng nhất. Cô chỉ mong các buổi không trùng giờ bác sĩ khám hoặc giờ phát thuốc. Cô cũng muốn nếu được thì cháu nhắc |  | Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ, kỹ năng xây dựng kế hoạch |

|                                                                                    |                                                       |  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | cô trước một chút để cô chuẩn bị.                     |  |                                                              |
| Dạ, cháu sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp và sẽ nhắc cô trước khi diễn ra hoạt động. | NB thể hiện sự tin tưởng cao; thái độ hợp tác rất tốt |  | Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ, kỹ năng xây dựng kế hoạch |

**Phụ lục 2.4. Phức trình buổi 4**

- Thông tin cá nhân của đối tượng: T.T.T
- Địa điểm thực hiện phức trình: Phòng bệnh
- Thời gian thực hiện phức trình: 10h00 – 10h30 ngày 22/9/2025
- Phức trình lần thứ: 4
- Mục tiêu buổi làm việc: **Hoạt động 1:** Kết nối với bác sĩ điều trị để cung cấp thông tin về lịch tái khám cho người bệnh
- Người thực hiện: Trần Thị Mai Hương

| <b>Mô tả nội dung phức trình</b>                                                                                 | <b>Cảm xúc &amp; hành vi của NB</b>                                                             | <b>Tự đánh giá cảm xúc của HV</b> | <b>Tự đánh giá kỹ năng, kỹ thuật sử dụng</b>                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chào cô ạ, hôm nay đến giờ mình làm việc với bác sĩ điều trị rồi. Cô có muốn chuẩn bị câu hỏi nào trước không ạ? | Ừ, cô muốn hỏi về lịch tái khám và xem cô có cần lên lại Hà Nội không, hay tái khám ở tỉnh được |                                   | Kỹ năng đặt câu hỏi<br>Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Dạ cháu chào bác sĩ. Cháu là Hương – học viên Công tác xã hội đang hỗ trợ cô T.T.T. Cô có một số băn khoăn       |                                                                                                 |                                   | Kỹ năng chuyển gửi                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| về lịch tái khám sau phẫu thuật. Mong bác sĩ hỗ trợ trao đổi thêm cho cô ạ.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |  |                                        |
| Chào cô, chào em. Cô cứ hỏi những điều cô đang thắc mắc nhé.                                                                                                                                                                                                                            | Dạ bác sĩ ơi... Cô muốn biết sau khi xuất viện thì bao giờ phải tái khám? Với lại cô ở xa, cô muốn hỏi có phải lên Hà Nội nữa không hay khám ở tỉnh được? |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Cô mổ ngày 12/9, đến nay vết mổ của cô đang hồi phục tốt. Không có dấu hiệu nhiễm trùng hay rỉ dịch. Đau còn nhiều nhưng là bình thường sau phẫu thuật. Nếu cô chăm sóc đúng hướng dẫn của điều dưỡng, vệ sinh sạch sẽ và theo dõi nhiệt độ cơ thể hằng ngày thì không có gì đáng ngại. | Cô nghe bác sĩ nói vậy cũng yên tâm hơn                                                                                                                   |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Cô sẽ cần tái khám sau 2 tuần kể từ                                                                                                                                                                                                                                                     | Vậy cô phải quay lại Hà Nội ạ?                                                                                                                            |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |  |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| ngày xuất viện để kiểm tra vết mổ và đánh giá mức độ hồi phục. Nếu mọi thứ ổn, lần tái khám tiếp theo sẽ là sau 6 tuần.                                                                                                    |                                                                                         |  |                                        |
| Nếu cô thấy khó khăn khi đi lại xa thì hoàn toàn có thể tái khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Ở đó có khoa sản đầy đủ thiết bị để kiểm tra vết mổ và tình trạng nội tiết. Cô chỉ cần mang giấy tờ xuất viện theo. | Ôi thế thì tốt quá. Cô lo nhất chuyện đi xa tốn kém... Nghe bác sĩ nói vậy cô đỡ lo hẳn |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Dạ cô, vậy cô có muốn hỏi thêm gì bác sĩ không ạ? Ví dụ về việc theo dõi vết mổ, ăn uống hay dấu hiệu bất thường?                                                                                                          | À đúng rồi. Bác sĩ cho cô hỏi, nếu vết mổ có đỏ hoặc đau hơn thì cô cần làm gì?         |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Nếu có đỏ, sưng, nóng, đau nhiều hoặc chảy dịch bất thường, cô cần đến bệnh viện gần nhất                                                                                                                                  | Ừ. Cô hiểu rồi. Cô cảm ơn bác sĩ nhé!                                                   |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| kiểm tra. Không cần phải lên Hà Nội. Quan trọng nhất là theo dõi kỹ.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |  |                                   |
| <p>Cháu xin phép tóm tắt lại để cô dễ nhớ:</p> <p>Cô tái khám lần 1 sau 2 tuần kể từ ngày xuất viện.</p> <p>Nếu đi lại khó khăn, cô có thể tái khám tại bệnh viện tỉnh Ninh Bình.</p> <p>Lần tái khám thứ 2 sẽ là sau 6 tuần.</p> <p>Nếu vết mổ có dấu hiệu bất thường, cô đến ngay bệnh viện gần nhất.”</p> | <p>Ừ, vậy cô yên tâm rồi. Cảm ơn bác sĩ và cháu nhé.</p> |  | <p>Kỹ năng cung cấp thông tin</p> |

**Phụ lục 2.5. Phức trình buổi 5**

- Thông tin cá nhân của đối tượng: T.T.T
- Địa điểm thực hiện phức trình: Phòng bệnh
- Thời gian thực hiện phức trình: 14h00 – 14h30 ngày 22/9/2025
- Phức trình lần thứ: 5
- Mục tiêu buổi làm việc: **Hoạt động 2:** Kết nối với điều dưỡng để hướng dẫn người bệnh cách chăm sóc, vệ sinh vết mổ
- Người thực hiện: Trần Thị Mai Hương

| <b>Mô tả nội dung phức trình</b>                                                                                                                                       | <b>Cảm xúc &amp; hành vi của NB</b>                               | <b>Tự đánh giá cảm xúc của HV</b> | <b>Tự đánh giá kỹ năng, kỹ thuật sử dụng</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Dạ chào chị điều dưỡng. Em là Hương – học viên Công tác xã hội. Hôm nay em hỗ trợ cô T.T.T trong buổi hướng dẫn chăm sóc và vệ sinh vết mổ. Mong chị hỗ trợ cô ạ       |                                                                   |                                   | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực       |
| Chào em, chào cô. Cô cứ thoải mái trao đổi, có gì chưa rõ thì hỏi cháu nhé.                                                                                            | Dạ... Cô cũng mong được hướng dẫn kỹ để về nhà đỡ lo              |                                   | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực       |
| Cô ơi, cháu kiểm tra vết mổ của cô trước nhé. Cô nằm thoải mái một chút. Vết mổ của cô liên tốt, không đỏ, không dịch. Chỉ hơi sưng nhẹ là bình thường sau phẫu thuật. | Thế thì cô yên tâm hơn... Máy hôm nay cô sợ nó bị nhiễm trùng.    |                                   | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực       |
| Bây giờ cháu hướng dẫn cô cách vệ sinh vết mổ tại nhà nhé:                                                                                                             | Cô cứ lo không biết có nên bôi nghệ không... Giờ thì cô hiểu rồi. |                                   | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |  |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| <p>1. Cô rửa tay bằng xà phòng thật sạch trước khi chạm vào vết mổ.</p> <p>2. Mỗi ngày vệ sinh vết mổ <b>2 lần</b> bằng nước muối sinh lý.</p> <p>3. Dùng gạc sạch thấm khô – không chà xát mạnh.</p> <p>4. Không tự ý bôi bất kỳ loại thuốc nào khi chưa có chỉ định.</p> |                                                                               |  |                                        |
| Cô cứ thực hiện như điều dưỡng nói thì sẽ an toàn hơn cho vết mổ ạ.                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| <p>Cô chú ý nếu có các dấu hiệu sau phải đi khám ngay:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vết mổ đỏ nhiều hoặc nóng rát</li> <li>- Chảy dịch vàng, xanh, có mùi</li> <li>- Sốt trên 38 độ</li> <li>- Đau tăng lên thay vì giảm dần</li> </ul>                    | <p>Cô sợ nhất là sốt... Nếu cô sốt thì đi bệnh viện tỉnh đúng không cháu?</p> |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Đúng rồi cô. Không cần lập tức lên Hà                                                                                                                                                                                                                                      | Ừ cô hiểu rồi. Cô nhờ cháu hướng                                              |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |

|                                                                                                                                 |                                                                   |  |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| Nội. Đến bệnh viện gần nhất là được.                                                                                            | dẫn cách vệ sinh vết mổ cho cả con gái cô nữa nhé                 |  |                                        |
| Giờ chị sẽ hướng dẫn em cách vệ sinh vết mổ nhé. Em nhìn chị làm mẫu trước.<br>Điều dưỡng làm mẫu: mở gạc – vệ sinh – thấm khô. | Dạ để em làm thử ạ.<br>Thực hành dưới sự quan sát của điều dưỡng. |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Đúng rồi, em làm vậy là chuẩn. Nhớ nhẹ tay và dùng gạc mới mỗi lần nhé.                                                         | Có con cô làm được như vậy thì cô yên tâm rồi.                    |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |

**Phụ lục 2.6. Phức trình buổi 6**

- Thông tin cá nhân của đối tượng: T.T.T
- Địa điểm thực hiện phức trình: Phòng bệnh
- Thời gian thực hiện phức trình: 14h00 – 14h30 ngày 23/9/2025
- Phức trình lần thứ: 6
- Mục tiêu buổi làm việc: **Hoạt động 3:** Kết nối với chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện để hướng dẫn người bệnh về chế độ dinh dưỡng phù hợp hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật
- Người thực hiện: Trần Thị Mai Hương

| Mô tả nội dung phức trình                             | Cảm xúc & hành vi của NB | Tự đánh giá cảm xúc của HV | Tự đánh giá kỹ năng, kỹ thuật sử dụng  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Dạ em chào chị.<br>Em là Hương – học viên Công tác xã |                          |                            | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| hội. Hôm nay em đưa cô T.T.T đến để được tư vấn dinh dưỡng sau phẫu thuật. Cô còn nhiều băn khoăn về chế độ ăn uống. Mong chị hỗ trợ ạ. |                                                                                                                                     |  |                                        |
| Chào cô, chào em. Cô cứ chia sẻ những điều cô đang lo lắng, cháu sẽ lần lượt giải thích cho cô hiểu.                                    | Cô thật sự rất muốn biết mình cần ăn gì cho nhanh hồi phục, với cô lo kiêng không đúng                                              |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Hiện giờ cô ăn uống thế nào rồi ạ?                                                                                                      | Cô ăn được nhưng không ngon miệng. Cô kiêng nhiều thứ... như thịt gà, rau muống, đồ nếp. Cô cũng không dám uống sữa vì sợ đầy bụng. |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Như vậy là cô đang bị kiêng hơi quá. Sau mổ cơ thể cần năng lượng và chất đạm để lành vết thương                                        | NB hơi bất ngờ, mở mắt to khi nghe “kiêng quá”                                                                                      |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Cô cần lưu ý 3 nguyên tắc:                                                                                                              | Thế là cô khỏi lo rồi... Cô cứ nghĩ ăn                                                                                              |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |  |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| <p>- Đủ đạm – giúp liền vết mổ: cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu.</p> <p>- Đủ Vitamin C – tăng miễn dịch: cam, ổi, bưởi, rau xanh.</p> <p>- Đủ nước – 1,5–2 lít mỗi ngày.</p> <p>Cô không cần kiêng tuyệt đối thịt gà hay đồ nếp như người ta vẫn nói.</p> | thịt gà là làm mừng mủ                             |  |                                        |
| Không ạ. Chỉ cần tránh đồ quá cay nóng, rượu bia là được.                                                                                                                                                                                               | NB nhẹ nhõm, gương mặt sáng hơn                    |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| <p>Với người mới mổ, cháu gợi ý cho cô thực đơn 1 ngày như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sáng: Cháo thịt băm, sữa tươi không đường.</li> <li>• Trưa: Cơm – cá kho – rau luộc – canh bí.</li> </ul>                                  | Cô thấy dễ ăn và dễ làm. Ở nhà cô nấu được như vậy |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |

|                                                                                                                                                  |                                                               |  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tối: Trứng luộc – súp rau củ – chuối hoặc cam.</li> <li>• Giữa bữa: 1 hộp sữa hoặc sữa chua.</li> </ul> |                                                               |  |                                        |
| Các bữa nên chia nhỏ, ăn ít nhưng ăn nhiều lần để tránh đầy bụng                                                                                 | NB gật đầu liên tục, ghi nhớ kỹ                               |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
|                                                                                                                                                  | Cô hỏi thêm... Cô bị táo bón sau mổ thì ăn gì cho dễ đi ngoài |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Cô tăng rau xanh, nước lọc, và ưu tiên trái cây như đu đủ, cam, bưởi. Cô có thể uống sữa chua mỗi ngày để tiêu hóa tốt hơn                       | Cô hay đau âm ỉ bụng dưới... ăn uống có ảnh hưởng không       |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
| Không cô nhé. Đau âm ỉ là bình thường sau mổ. Ăn uống lành mạnh giúp hồi phục nhanh hơn                                                          | Vậy... cô có cần uống thêm vitamin hay thuốc bổ không         |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |

|                                                                      |                                      |  |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------------|
| Nếu cô ăn uống đủ chất thì không cần. Chỉ bổ sung khi bác sĩ kê thêm | NB thoải mái hơn, mạnh dạn hỏi nhiều |  | Kỹ năng kết nối và điều phối nguồn lực |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------------|

**Phụ lục 2.7. Phúc trình buổi 7**

- Thông tin cá nhân của đối tượng: T.T.T
- Địa điểm thực hiện phúc trình: Phòng bệnh
- Thời gian thực hiện phúc trình: h00 – 14h30 ngày 24/9/2025
- Phúc trình lần thứ: 7
- Mục tiêu buổi làm việc: Lượng giá kết quả các hoạt động
- Người thực hiện: Trần Thị Mai Hương

| <b>Mô tả nội dung phúc trình</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cảm xúc &amp; hành vi của NB</b>                 | <b>Tự đánh giá cảm xúc của HV</b> | <b>Tự đánh giá kỹ năng, kỹ thuật sử dụng</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Hôm nay cháu đến để trao đổi với cô về các hoạt động mà mình đã làm trong mấy ngày qua: gặp bác sĩ, buổi hướng dẫn chăm sóc vết mổ, và tư vấn dinh dưỡng. Cháu muốn nghe cảm nhận của cô để xem những hoạt động đó giúp cô như thế nào và còn điều gì cô mong muốn được | Ừ, được cháu. Cô cũng muốn xem mình nắm đến đâu rồi |                                   |                                              |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                         |  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| hỗ trợ thêm. Cô thấy mình sẵn sàng trao đổi chưa ạ?                                      |                                                                                                                                                                         |  |                     |
| Cô nhớ hôm mình gặp bác sĩ hôm 22/9 không ạ? Cháu muốn hỏi buổi đó giúp cô được điều gì? | Buổi đó giúp cô yên tâm nhiều. Bác sĩ nói rõ lịch tái khám, rồi bảo cô có thể khám ở tỉnh. Trước cô cứ nghĩ phải lên Hà Nội, giờ biết vậy thấy nhẹ hẫng.                |  |                     |
| Nếu chấm mức độ hữu ích từ 1 đến 5, thì cô cho bao nhiêu ạ?                              | Cô cho 5. Buổi đó quan trọng nhất với cô                                                                                                                                |  |                     |
| Hôm điều dưỡng hướng dẫn vệ sinh vết mổ, cô cảm thấy sao ạ?                              | À, buổi đó cô học được nhiều lắm. Trước cô sợ không dám đụng vào vết mổ, giờ biết rửa, biết lau, biết theo dõi. Con gái cô học được cách làm, cô yên tâm nhất khoản đó. |  |                     |
| Vậy mức độ hữu ích cô đánh giá là thế nào ạ?                                             | Cũng 5. Cô không còn sợ như trước nữa                                                                                                                                   |  | Kỹ năng đặt câu hỏi |
| Hôm qua mình được tư vấn dinh                                                            | Cô thấy rõ ràng hẫng. Trước kiêng                                                                                                                                       |  | Kỹ năng đặt câu hỏi |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <p>duỡng, cô thấy sao ạ?</p>                                                                        | <p>đủ thứ, giờ biết ăn đúng để mau khỏe. Cô cũng biết phải uống nhiều nước, ăn trái cây, ăn chia bữa. Nói chung cô bớt lo vụ ăn uống rồi</p>                       |  |                     |
| <p>Sau 3 buổi làm việc, cô thấy mình thay đổi thế nào so với lúc mới nhập viện?</p>                 | <p>Khác nhiều cháu ạ. Trước cô lo lắng, giờ bớt hẳn. Giờ cô hiểu cách chăm, hiểu gì cần ăn, hiểu lúc nào cần đi khám. Cô thấy có cái để bám vào nên tự tin hơn</p> |  | Kỹ năng đặt câu hỏi |
| <p>Cô còn băn khoăn gì không ạ?</p>                                                                 | <p>Chỉ còn hơi đau khi đứng lên, nhưng cái đó chắc do mới mổ. Cô cũng muốn biết tập thế nào cho mau hồi phục</p>                                                   |  | Kỹ năng đặt câu hỏi |
| <p>Nếu theo thang từ 1 đến 5 về mức độ hài lòng với các buổi làm việc, cô đánh giá bao nhiêu ạ?</p> | <p>Cô cho 5. Cô thấy các buổi rất thiết thực, dễ hiểu. Cô được giải thích kỹ càng nên bớt lo</p>                                                                   |  | Kỹ năng đặt câu hỏi |
| <p>Cô mong muốn buổi tiếp theo sẽ tập</p>                                                           | <p>Cô muốn biết bài tập nào nhẹ nhàng,</p>                                                                                                                         |  | Kỹ năng đặt câu hỏi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| trung vào nội dung gì?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | và khi nào cô làm được việc nhà                                                                                 |  |  |
| Dạ vâng, hôm nay thì cũng là buổi kết thúc đợt thực tập của cháu cũng như là kết thúc các hoạt động cháu cùng với cô thực hiện ạ. Cháu cảm ơn cô đã cùng hợp tác và tham gia rất tích cực vào các hoạt động hỗ trợ. Theo như đánh giá của cô thì cô cảm thấy rất hài lòng với các hoạt động. Cháu kính chúc cô mạnh khỏe và sớm ra viện ạ | Cô cảm ơn cháu đã hỗ trợ giúp cô có thêm kiến thức cũng như an tâm hơn để chăm sóc cho bản thân sau khi ra viện |  |  |

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG**

**KHOA KHXH & HV**

**BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA**

**BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP NÂNG CAO**

**Họ và tên học viên:** Trần Thị Mai Hương

**Cơ sở thực tập:** Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

**Tên đề tài:** Quản lý trường hợp với người bệnh u xơ tử cung, tại khoa Bệnh Phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, năm 2025

**Lớp:** ThSCTXH1-1B

| STT | Nội dung góp ý của Hội đồng                                                                                                                                                                         | Nội dung đã chỉnh sửa theo góp ý                                                 | Nội dung không chỉnh sửa – giải trình lý (nếu có) | Ghi chú (số trang của nội dung chỉnh sửa theo góp ý) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | Thống nhất thuật ngữ: thực tập thay vì thực hành cho đúng với tên của học phần                                                                                                                      | Học viên đã rà soát và điều chỉnh thành thuật ngữ thực tập trong toàn bộ báo cáo |                                                   | Toàn bộ báo cáo                                      |
| 2   | Trong phần cây vấn đề, kế hoạch không có nội dung liên quan đến tâm lý tuy nhiên phần kỹ năng thực hiện có kỹ năng tham vấn: xử lý khủng hoảng => HV lý giải về nội dung này vì phân phụ lục có khả | Học viên đã lược bỏ kỹ năng xử lý khủng hoảng để phù hợp hơn với vấn đề của NB   |                                                   | Trang 32                                             |

|   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
|   | năng xử lý khủng hoảng (trang 48)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |
| 3 | Bổ sung số của phụ lục (ví dụ trang 33 bước 4 theo dõi, rà soát,...)                                                       | Học viên đã bổ sung thêm số của phụ lục                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Trang 33  |
| 4 | Lượng giá các kết quả có thể hiện qua phụ lục nào không? Ví dụ làm sao để đánh giá được nắm được thông tin, kiến thức,.... | Kết quả lượng giá chủ yếu học viên thực hiện thông qua 02 biểu mẫu Phiếu đánh giá kết quả can thiệp để đánh giá lại mức độ vấn đề của NB và Phiếu đánh giá mức độ hài lòng của đối tượng chứ chưa thực sự lượng giá được mức độ NB nắm được thông tin kiến thức. Do vậy, học viên đã bổ sung thêm vào phần hạn chế |  | Trang 41  |
| 5 | Học viên bổ sung Phúc trình ca theo tiến trình các bước QLTH                                                               | Học viên đã bổ sung thêm các phúc trình ca theo quy định                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Phụ lục 2 |

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

**Sinh viên**  
(ký, họ tên)